

我が国における発達障害のある子どもの親に対する ペアレントトレーニングの研究動向 ——系統的レビューによるアップデート——

所沢市こども支援センター^(注1) 山口穂菜美

取手市役所 吉本 茜

国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 原口英之

本研究では、我が国の発達障害のある子どもの親に対するペアレントトレーニング (parent training: PT) に関するエビデンスをアップデートすることを目的に、国内の PT の実践研究を系統的にレビューした。2012 年から 2018 年に発刊された研究論文 50 本 (研究数 51) を抽出し、サンプルサイズ、子どもの特徴、PT プログラムの特徴、効果評価の特徴、効果を分析した。サンプルサイズの平均は親が 11、子どもが 10 であった。研究の 69% が学童期、59% が幼児期の子どもを、そして 80% が確定診断のある子どもを対象としていた。35% が国内の代表的な PT プログラムの研究であった。親への効果は、77% が標準化された検査・尺度、18% が観察データを用い、80% が事前事後テストデザイン、16% が単一事例実験デザインにより評価していた。子どもへの効果は、55% が標準化された検査・尺度、29% が観察データを用い、57% が事前事後テストデザイン、28% が単一事例実験デザインにより評価していた。介入群と対照群の比較研究は 6 件あった。多くの研究により PT を受けた親子の多様なアウトカムの改善が示され、PT の効果に関する一定の知見が得られた。しかし、我が国の PT 研究は、サンプルサイズが小さく、群間比較研究が少なかった。また、対象やプログラムに関する詳細な情報や、実行度、参加率、プログラムの評価の報告が不足していた。今後、より厳密な研究デザインを用いた研究の蓄積と、PT の対象、プログラム、評価に関する詳細な報告が求められる。

Key Words ペアレントトレーニング、発達障害、効果、エビデンス、系統的レビュー

問題と目的

発達障害のある子どもとその親への支援の充実
は世界共通の課題である。発達障害のある子どもの親に対するペアレントトレーニング (parent training: 以下、PT とする) は、親が子どもに対する適切な支援方法を身につけることで子どもの行動の改善や発達の促進を目指す介入アプローチであり、現在、世界的な普及が目指されている。世界保健機構 (World Health Organization: WHO) は、発達障害のある子どもへの介入の一つとして PT (caregiver skills training: CST) を推奨し、各国でのフィールドテストを開始したところである (WHO, n. d.)。

これまで海外における発達障害の PT のエビデンスに関しては障害種別に検証され蓄積されてきた。近年の系統的レビューやメタアナリシスによると、自閉スペクトラム症 (autism spectrum

disorder: ASD) のある子どもの親への PT については、子どもの問題行動の改善 (Postorino et al., 2017; Tarver et al., 2019)、言語理解力の向上 (Oono, Honey, & McConachie., 2013)、ASD 症状の低減 (Oono et al., 2013)、親子の相互交流 (parent-child interaction) の肯定的変化 (Oono et al., 2013) に関する有効性が示されている。親のストレスに対しては、低減効果が明確であった研究 (Tarver et al., 2019) と、明確でなかった研究 (Oono et al., 2013) があり、結果が混在している。注意欠如・多動症 (attention deficit hyperactivity disorder: ADHD) のある子どもの親への PT については、親の評価による、子どもの行動問題の改善や ADHD 症状の低減、親の養育の質の改善に関する有効性が示されている (Daley et al., 2014; Rimestad, Lambek, Christiansen, & Hougaard, 2019)。一方で、独立した評価者 (independent assessor) による評価では、親の養育の質と子どもの問題行

動の改善の有効性は示されているが、ADHD 症状の低減に対する有効性は示されていない (Daley et al., 2014; Rimestad et al., 2019)。各レビューの目的、対象に含めた研究は異なり、また、各レビューの対象となった個々の研究の参加者や介入 (PT) の特徴、アウトカム指標等の違いにより、一部結果が一致しないことが示されているものの、多くのレビューで PT の有効性が支持されている。一方で、エビデンスの質に関する課題が指摘され、さらなる実証的研究の蓄積が必要であるとされている。

我が国では、発達障害者支援法において家族支援の重要性が謳われ、国の発達障害者支援施策として PT の普及が推進されているところである (厚生労働省, n. d.)。しかしながら、国内の PT の研究は少なく研究の質についても課題が多いことから、国内の PT に関するエビデンスは限られている。1994 年から 2011 年までに国内で報告された PT 研究の系統的レビュー (原口・上野・丹治・野呂, 2013) では、対象論文 47 本のうち約半数の研究で客観的な指標や方法論を用いた効果検証が実施されていなかったことが明らかにされており、そのため PT の効果について全体として論じることは妥当ではないとされている。今後の課題として、「根拠に基づく実践 (evidence-based practice)」という視点から、PT による親子両方への効果評価を客観的に行っていく必要性が指摘されている。

発達障害のある子どもの親への PT に関する研究は国際的に増加しており、最新の研究にアクセスしエビデンスの現状をレビューすることは常に重要な研究課題である。我が国においても、PT に関する研究が現在どのように行われているか、そしてどのような結果が得られているかについて最新の情報を集約することが望まれる。そこで本研究は、原口他 (2013) 以降に報告された国内の PT 研究を系統的にレビューし、国内の PT に関するエビデンスをアップデートすることを目的とする。

方 法

本研究は、国内の PT 研究の系統的レビュー

(原口他, 2013) と PT に関する最新の全国調査 (一般社団法人日本発達障害ネットワーク JDDnet, 2020) の知見を踏まえ、系統的レビューのガイドラインである PRISMA (preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses) 声明 (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & The PRISMA Group, 2009) の基準を参考に実施した。

対象論文の選定

国立情報学研究所 NII 学術情報ナビゲータ (CiNii) 及び医学中央雑誌 (医中誌) を使用し、「ペアレントトレーニング」「親指導」「保護者指導」「親支援」「保護者支援」「親訓練」「保護者訓練」のキーワードで検索を行った (2019 年 7 月)。出版年は 2012 年から 2018 年に発行されたものとした。本研究では、発達障害のあるもしくは疑われる子どもの親を対象とした PT に関する研究論文であり、(1) 学会、(2) 職能団体、(3) 大学のいずれかが発行している学術論文、(4) 出版社から発行され投稿規定もしくは執筆要綱が定められている学術論文、(5) 研究助成論文、のいずれかを満たす論文の中から、実践研究を抽出した。抄録、会議録、解説、総説、調査研究、PT の一部を紹介した報告は除外した。選定は、第一著者と第二著者が独立して実施し、選定の判断が一致しなかった場合には第三著者を交えて協議し決定した。なお、3 名とも発達障害のある子どもの親への PT の実践及び研究の経験を有する者であった。

対象論文の分析

分析項目は、サンプルサイズ、子どもの特徴、PT プログラム、実施者、クオリティコントロール、子どもへの介入、効果評価指標、効果評価方法、効果、実行度 (implementation fidelity)、参加率、プログラムの評価とした。第一著者と第二著者が独立して分析項目に沿ってデータを抽出し、記述した (付録 1・2)。記述内容が一致しなかった場合には、第三著者を交えて協議し決定した。

サンプルサイズ 研究対象である親と子どもの人数を記述した。

子どもの特徴 対象の子どもの年齢について、未就学児を「幼児期」、小学生を「学童期」、中学

生以上を「青年期」に分類した。年齢に関して記載のないものは「不明」とした。年齢の平均や範囲等がわかるものは記述した。診断については、「診断ありのみ」、「一部診断あり」（診断のある者となない者が含まれる）、「診断なしのみ」に分類し、記載のないものや判断できないものは「不明」とした。診断ありの場合で、具体的な診断名がわかるものは記述した。

PTプログラム 国内で開発・検証され、マニュアル化されている代表的なプログラムである「精研式・まめの木式・奈良式」「肥前式」「鳥取大式」「トリプルP」と、それらのプログラムを参考にしたプログラムに分類し、それ以外のものを「その他」とした。プログラムの実施形態を「集団（集団＋個別も含む）」か「個別」に分類した。また、セッティング（実施場所）を記述し、分類した。具体的な頻度、合計回数、期間、フォローアップの有無がわかるものは記述した。

実施者 PTの実施者の資格（国家資格もしくは公的資格）等について記述し、分類した。

クオリティコントロール PTを実施する際の実施者への研修、認定、スーパーバイズ、実行度の評価方法等の記載の有無について記述した。

子どもへの介入 PT実施者・実施機関による子どもに対する直接介入（療育、SST等）の実施の有無について記述した。

効果評価指標 親及び子どもの効果評価の指標として、標準化された「検査・尺度」、標的行動の頻度等の「観察データ」、それ以外を「その他」に分類した。「検査・尺度」については具体的に抽出し、類似するカテゴリーに分類、集計した。「観察データ」については測定された行動を類似するカテゴリーに分類し、集計した。また、観察者間一致率の測定の有無について記述した。

効果評価方法 効果を検証するための研究デザインについて、「事前事後テストデザイン」、「事後テストデザイン」、「単一事例実験デザイン」、「その他」に分類した。「事前事後テストデザイン」については群間比較の有無について記述した。「単一事例実験デザイン」については、Barlow & Hersen (1984) を参考に具体的に分類した。また、統計解析の有無について記述した。有

意水準は0.05とした。

効果 「検査・尺度」または「観察データ」を用い、かつ「事前事後テストデザイン」または「単一事例実験デザイン」で実施された研究について、論文に記載された効果に関する主要な結果を記述した。

実行度 (implementation fidelity) PTの実施の実行度に関する結果の記載の有無について記述した。

参加率 集団形態のPTの出席者もしくは中断者の人数等、参加率や中断率に関する記載の有無について記述した。

プログラムの評価 PTプログラムに対する感想や満足度などのアンケート、社会的妥当性等、プログラムそのものに対する評価の記載の有無について記述した。

分析方法

単純集計を行い各分析項目の結果を計数及び割合（％）で示した。

結果

対象論文

選定過程を図1に示す。キーワード検索にて計1306件（CiNii 839件；医中誌467件）の論文が該当した。重複した201件を除外した1105件について、雑誌、タイトル、アブストラクトにてスクリーニングを行った後、全文を精読し適格性の評価を行った結果、50本の論文が選定された。なお、1つの論文で2つの研究報告がなされていたため研究数は51件であった。年間の発刊本数は平均7.1本であり、最も多かったのは11本（2015年）、少なかったのは3本（2016年）であった（図2）。

サンプルサイズと子どもの特徴（表1）

親のサンプルサイズが記載されている研究は50件あり、サンプルサイズの平均は10.6 ($SD=10.54$, range 1-48) であった。子どものサンプルサイズが記載されている研究は46件あり、サンプルサイズの平均は10.0 ($SD=9.84$, range 1-48) であった。

子どもの年齢は、学童期が35件（68.6％）と

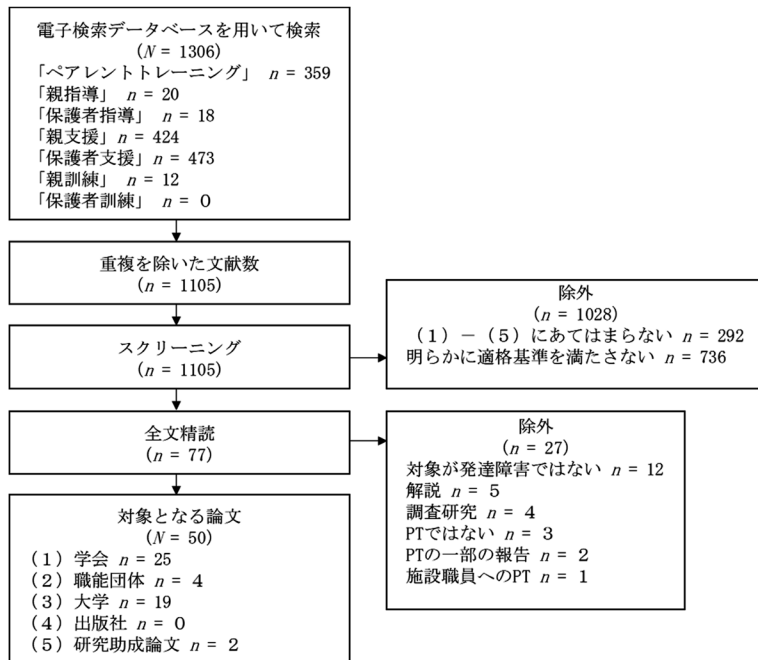


図1 選定過程

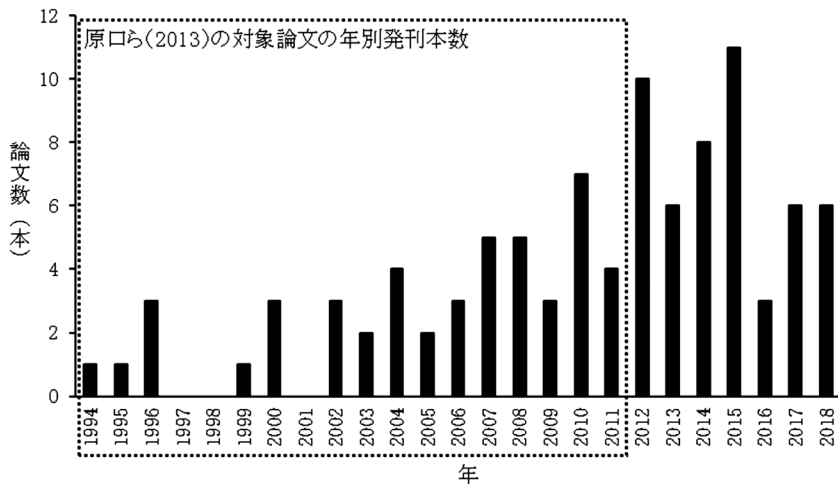


図2 年別発刊本数

本研究のデータに、原口ら（2013）の対象論文（1994～2011 に発刊された論文）のデータを加えて作成

最も多く、幼児期が30件（58.8%）、青年期が8件（15.7%）であった。子どもの診断については、診断のある子どものみを対象としたものが25件（49.0%）と最も多く、診断のある子どもとない子どもが含まれているものが16件（31.4%）、診断のない子どものみを対象としたものが3件（5.9%）、不明なものが7件（13.7%）あった。

PTプログラムの特徴（表2）

精研式・まめの木式・奈良式が11件（21.6%）、肥前式とトリプルPがそれぞれ3件（5.9%）、鳥取大式が1件（2.0%）であった。その他が33件（64.7%）あり、ビデオフィードバックの方法を用いたPT（石塚・狩野，2017；神山，2017；杉原・米山，2014；杉原・米山，2015；上野・野呂，2012；上野・高浜・野呂，2012）や実施機関独自

表1 サンプルサイズと子どもの特徴

	合計 (N=51)
サンプルサイズ (親)	
n	50
平均 (SD)	10.6 (10.54)
範囲	1-48
サンプルサイズ (子ども)	
n	46
平均 (SD)	10.0 (9.84)
範囲	1-48
子どもの年齢 (複数有)	
幼児期	30 (58.8)
学童期	35 (68.6)
青年期	8 (15.7)
子どもの診断	
ありのみ	25 (49.0)
一部あり	16 (31.4)
なしのみ	3 (5.9)
不明	7 (13.7)

() 内に割合 (%) を示す

のプログラム (例えば、岡島他, 2014; 奥野他, 2013; 奥野他, 2014) が多かった。

プログラムの実施形態は、集団が42件 (82.4%) (論文数は41本)、個別が9件 (17.6%) であった。セッティングは、大学が14件 (27.5%) と最も多く、学校が5件 (9.8%)、医療機関が4件 (7.8%)、保健センター、福祉機関、家庭がそれぞれ3件 (5.9%) であった。その他が7件 (13.7%) あり、教育センター (水内・阿部, 2012) やインターネット電話 (神山・竹中, 2016) 等であった。セッティングの不明なものは15件 (29.4%) あった。実施者は、心理士が14件 (27.5%)、学校教員と医師がそれぞれ6件 (11.8%)、保健師と作業療法士がそれぞれ2件 (3.9%)、看護師が1件 (2.0%) であった。その他は23件 (45.1%) あり、大学教職員、大学院生、トリプルP認定専門家、発達相談センター職員、発達支援コーディネーター、教育センター研究主事、事業所職員、行動セラピスト等であった。実施者の資格等詳細な情報が不明なものは13件 (25.5%) あった。クオリティコントロールに関する記載のあった研究は13件 (25.4%) であった。PTと並行して、子どもに対する療育やソーシャルスキルトレーニング (social skills training: SST) 等の直接介入が実施されていた研究が20件

表2 PTプログラムの特徴

	合計 (N=51)
PT プログラム	
精研式・まめの木式・奈良式	11 (21.6)
肥前式	3 (5.9)
トリプルP	3 (5.9)
鳥取大式	1 (2.0)
その他	33 (64.7)
フォローアップ	
あり	10 (19.6)
実施形態	
集団	42 (82.4)
個別	9 (17.6)
セッティング (複数有)	
大学	14 (27.5)
学校	5 (9.8)
医療機関	4 (7.8)
保健センター	3 (5.9)
福祉機関	3 (5.9)
家庭	3 (5.9)
その他	7 (13.7)
不明	15 (29.4)
実施者 (複数有)	
心理士	14 (27.5)
学校教員	6 (11.8)
医師	6 (11.8)
保健師	2 (3.9)
作業療法士	2 (3.9)
看護師	1 (2.0)
その他	23 (45.1)
不明	13 (25.5)
クオリティコントロール	
記載あり	13 (25.4)
子どもへの介入	
あり	20 (39.2)

() 内に割合 (%) を示す

(39.2%) あった。

効果評価の特徴 (表3)

親への効果の評価指標については、検査・尺度を用いたものが39件 (76.5%) で最も多く、観察データが9件 (17.6%)、その他が16件 (31.4%)、効果評価を行っていないものが1件 (2.0%) あった。検査・尺度と観察データを併用したものが3件あった (付録3)。検査・尺度について具体的に分類した結果 (表4)、「抑うつ・不安・ストレス」が25件 (49.0%)、「行動理論の知識」が15件 (29.4%)、「精神健康」が11件 (21.6%)、「セルフエフィカシー」が9件 (17.6%)、「親子関係」が5件 (9.8%)、「養育行

表3 効果評価の特徴

	親 (N=51)	子 (N=51)
効果評価指標 (複数有)		
検査・尺度	39 (76.5)	28 (54.9)
観察データ	9 (17.6)	15 (29.4)
その他	16 (31.4)	6 (11.8)
なし	1 (2.0)	9 (17.6)
効果評価方法 (複数有)		
事前事後テストデザイン	41 (80.4)	29 (56.9)
群間比較 (介入群 vs 対照群)	6 (11.8)	6 (11.8)
群間比較 (その他)	4 (7.8)	4 (7.8)
単一事例実験デザイン	8 (15.7)	14 (27.5)
事後テストデザイン	1 (2.0)	3 (5.9)
その他	11 (21.6)	3 (5.9)
なし	1 (2.0)	9 (17.6)
統計解析有	27 (52.9)	20 (39.2)
実行度		
記載あり	1 (2.0)	
参加率		
記載あり	24 (47.1)	
プログラムの評価		
記載あり	28 (54.9)	

動」が3件 (5.9%)、その他が6件 (11.8%) の研究で用いられていた。観察データについては、「養育行動」(子どもとの適切なかわり方等) が4件 (7.8%)、「指導スキル」(プロンプトや強化等の指導技法) が7件 (13.7%) の研究で用いられており、観察者間一致率については8件 (観察データを使用した研究9件のうちの88.9%) で測定されていた。親への効果の評価方法については、事前事後テストデザインが41件 (80.4%) で最も多かった。そのうち群間比較を行っているものが10件 (19.6%) あり、介入群と対照群の比較が6件 (11.8%)、具体的には、PTを受けた群と受けなかった群の比較 (Matsuo, Inoue, & Maegaki, 2015; 松尾・井上, 2013; 西嶋・松浦・星田, 2015)、PTとSSTを受けた群と通常治療を受けた群の比較 (岡島他, 2014)、PTとSSTを受けた群とSSTのみを受けた群の比較 (富尾他, 2018)、PTとサマー・トリートメント・プログラム (STP) を受けた群とSTPのみを受けた群及び対象児の障害種別の群の比較 (免田・向笠・家村・山下・松石, 2015) であった。それ以外の群間比較研究4件 (7.8%) は、PTとSSTを受けた群とPTのみを受けた群の比較 (簗・小嶋・

小林・田上, 2017)、PTを1回受けた群と2回受けた群の比較 (免田, 2015)、PTを受けた対象児の障害種別の群の比較 (富澤・佐藤・横山, 2013; 奥野他, 2013) を実施した研究であった。単一事例実験デザインは8件 (15.7%) で、そのうちの2件が参加者間多層ベースラインデザイン、それ以外はA-Bデザインもしくはベースラインのない介入フェイズのみのデザインであった。事後テストデザインは1件 (2.0%) であった。なお、親への効果に関して、評価指標別に評価方法を見ると、検査・尺度を用いた39件の研究は全て事前事後テストデザインを使用しており、観察データを用いた9件の研究のうち8件が単一事例実験デザイン、1件が事前事後テストデザインを使用していた。親への効果の評価方法として統計解析が行われていた研究は27件 (52.9%) であった。

子どもへの効果の評価指標については、検査・尺度を用いたものが28件 (54.9%) と最も多く、観察データが15件 (29.4%)、その他が6件 (11.8%)、効果評価を行っていないものが9件 (17.6%) あった。検査・尺度と観察データを併用したものが3件あった (付録3)。検査・尺度について具体的に分類した結果 (表5)、「問題行動」が18件 (35.3%)、「発達障害特性」が5件 (9.8%)、「発達・知的能力」が3件 (5.9%)、「ソーシャルスキル」が2件 (3.9%)、「その他」が3件 (5.9%) の研究で用いられていた。観察データについては、「日常生活スキル」(身辺自立スキル、持ち物の準備・片付け等) が9件 (17.6%)、「対人行動・コミュニケーション」(社会的スキル、コミュニケーションスキル等) が5件 (9.8%)、「認知・学習」(療育課題、学習課題等) が4件 (7.8%)、「問題行動」が2件 (3.9%) の研究で用いられており、観察者間一致率については8件 (観察データを使用した研究15件のうちの53.3%) で測定されていた。子どもへの効果の評価方法については、事前事後テストデザインが29件 (56.9%) で最も多かった。そのうち群間比較を行っているものが10件 (19.6%) あり、介入群と対照群の比較が6件 (11.8%)、それ以外の比較が4件 (7.8%) で、親への効果評価の

表 4 親への効果の評価指標に用いられた検査・尺度等（複数有）

分類・検査・尺度名	合計（N=51）
抑うつ・不安・ストレス	25 (49.0)
BDI-II（小嶋・古川，2003）	9 (17.6)
QRS（山上，1998）	8 (15.7)
新版 STAI（肥田野・福原・岩脇・曾我・Spielberger, 2000）	3 (5.9)
PSI/PS-SF（奈良間他，1999）	3 (5.9)
DASS（Lovibond & Lovibond, 1995）	2 (3.9)
育児負担感（中嶋・齋藤・岡田，1999）	1 (2.0)
育児不安尺度（手島・原口，2014）	1 (2.0)
SRS-18（鈴木他，1997）	1 (2.0)
障害児育児ストレス認知尺度（岡田・種子田・新田・中嶋，2004）	1 (2.0)
行動理論の知識	15 (29.4)
KBPAC（保坂・池田，1980; 金・米山，2017; 大野他，2005; O'Dell, Tarler-Benlolo, & Flynn, 1979; 志賀，1983; 梅津，1982）	15 (29.4)
精神健康	11 (21.6)
GHQ-30/28/12（Goldberg, 1978; 中川・大坊，1996）	11 (21.6)
セルフエフィカシー	9 (17.6)
CDQ（岩坂，2012）	6 (11.8)
SE-Ⅲ式（Coopersmith, 1967）	1 (2.0)
PSES（田坂，2003）	1 (2.0)
PSAM（田坂，2003）	1 (2.0)
親子関係	5 (9.8)
TK 式診断的新親子関係検査（品川・品川・森上・河井，1972）	2 (3.9)
FDT 親子関係診断検査（東・柏木・繁多・唐澤，2002）	1 (2.0)
CBQ（Robin, 1981）	2 (3.9)
養育行動	3 (5.9)
PS（Arnold, O'Leary & Acker, 1993）	2 (3.9)
養育スタイル尺度（松岡他，2011）	1 (2.0)
その他	6 (11.8)
PES（Sanders, Markie-Dadds, Rinaldis, Firman & Baig, 2007）	2 (3.9)
FES（涌水他，2010）	1 (2.0)
FAS（Fujita et al., 2002）	1 (2.0)
SUBI（大野・吉松，2001）	1 (2.0)
育児感情尺度（山川・柏木，2004）	1 (2.0)

（ ）内に割合（％）を示す

BDI-II = ベック抑うつ質問票，QRS = Questionnaire on Resources and Stress，新版 STAI = 新版 STAI 状態 - 特性不安検査，PSI = PSI 育児ストレスインデックス，PS-SF = 育児ストレスショートフォーム，DASS = Depression, Anxiety, Stress Scale，SRS-18 = 心理的ストレス反応尺度，KBPAC = Knowledge of Behavioral Principles as Applied to Children，GHQ = GHQ 精神健康調査票，CDQ = 家族の自信度調査票，SE-Ⅲ式 = クーパースミスの全般的セルフエスティーム尺度，PSES = 育児自己効力感尺度，PSAM = Parental Self-Agency Measure，CBQ = 葛藤行動質問票，PS = Parenting Scale，PES = Parenting Experience Survey，FES = Family Empowerment Scale，FAS = Family Attitude Scale，SUBI = Subjective Well-Being Inventory

方法で示した研究と同様であった。単一事例実験デザインは 14 件（27.5％）で、そのうちの 2 件が参加者間多層ベースラインデザイン、それ以外は A-B デザインもしくはベースラインのない介入フェイズのみのデザインであった。事後テストデザインは 3 件（5.9％）であった。なお、子どもへの効果に関して、評価指標別に評価方法を見ると、検査・尺度を用いた 28 件の研究は全て事前事後テストデザインを使用しており、観察デー

タを用いた 15 件の研究のうち 14 件が単一事例実験デザイン、1 件が事前事後テストデザインを使用していた。子どもへの効果の評価方法として統計解析が行われていた研究は 20 件（39.2％）であった。

親及び子どもへの効果に関する評価指標の組み合わせ（付録 3）を見ると、親と子ども両方で検査・尺度のみを使用した研究が 18 件（35.3％）、親と子ども両方で観察データのみを使用した研究

表5 子どもへの効果の評価指標に用いられた検査・尺度等（複数有）

分類	合計（N=51）
問題行動	18 (35.3)
CBCL（井潤他, 2001）	11 (21.6)
SDQ（Goodman, 1999）	7 (13.7)
HSQ（Altepeter & Breen, 1989）	4 (7.8)
発達障害特性	5 (9.8)
ADHD-RS（山崎・小石・朝倉, 2000）	3 (5.9)
CARS	1 (2.0)
SRS（Constantino & Gruber, 2005）	1 (2.0)
発達・知的能力	3 (5.9)
KIDS	1 (2.0)
新版 K 式発達検査	1 (2.0)
田中ビネー知能検査	1 (2.0)
WISC- III /WISC- IV	1 (2.0)
ソーシャルスキル	2 (3.9)
家庭における社会的スキル尺度（戸ヶ崎・坂野, 1997）	1 (2.0)
ソーシャルスキル尺度（上野・岡田, 2006）	1 (2.0)
その他	3 (5.9)
旭出式社会適応スキル検査（旭出学園教育研究所, 2012）	1 (2.0)
COPM（Law et al, 1998 吉川・上村監訳 2001）	1 (2.0)
SCERTS プロフィール（Prizant, Wetherby, Rubin, Laurent, & Rydell, 2006 長崎・吉田・仲野監訳 2010）	1 (2.0)

（ ）内に割合（％）を示す

CBCL=Child Behavior Checklist, SDQ=子どもの強さと困難さアンケート, HSQ=家庭状況調査票, ADHD-RS=ADHD Rating Scale- IV, CARS=小児自閉症評定尺度, SRS=対人応答性尺度, KIDS=KIDS 乳幼児発達スケール, COPM=カナダ作業遂行測定

が5件（9.8％）であった。親と子ども両方で検査・尺度と観察データを併用した研究は1件（2.0％）であった。

実行度に関するデータの記載があった研究は神山・澤田・岸（2016）の1件（2.0％）であった。PT実施者が、各回で「時間内に予定の内容を全て説明できたかどうか」「保護者自らが子育ての工夫に気付くことを促せたかどうか」「保護者が全員演習において用紙に記入できたかどうか」「保護者の質問に回答できたかどうか」を、「できた」または「できなかった」の2段階で自己評価を行っており、第4回の「時間内に予定の内容を全部説明できたかどうか」以外、各回いずれの項目とも「実施できた」と評価された。参加率に関する記載があった研究は24件（47.1％）、プログラムの評価に関する記載があった研究は28件（54.9％）であった。

効果

本研究で、親への効果を記述できた研究は45

件（88.2％）であった。全体として、検査・尺度を指標とした事前事後テストデザインを用いた研究では、PTを受けた親の抑うつ・不安・ストレス、精神健康、セルフエフィカシー、行動理論に関する知識、親子関係、養育行動の改善が示されていた。しかしながら、介入群と対照群の群間比較を行った6つの研究からは、抑うつ・不安・ストレスの変化に関して様々な結果が示されていた。抑うつに関しては、Matsuo et al.（2015）では、両群にBDIの得点の有意な改善が認められたが、松尾・井上（2013）では、両群ともBDIの得点の変化は有意ではなかった。ストレスに関して、介入前後のSRS-18得点の変化量を群間比較した岡島他（2014）では、介入群の変化量が対照群の変化量に比べて有意に大きかったこと（改善）が、介入前後のPSIの得点を群別に比較した富尾他（2018）では、介入群のみ有意に改善したことが示されていた。一方、免田他（2015）では、両群ともQRSの得点に有意な変化はなかった。また、抑うつ・不安・ストレスに関して、西嶋他

(2015) では、両群とも DASS の得点に有意な変化がなかったことが示されていた。セルフエフィカシーに関しては、岡島他 (2014) では、介入群の PSES の得点は改善したものの、その変化量については有意な群間差は見られなかった。親子関係に関しては、CBQ 得点において、松尾・井上 (2013) では、両群とも有意な変化がなく、Matsuo et al. (2015) では、対照群と比べて介入群に有意な改善が示されていた。養育行動に関しては、西嶋他 (2015) では、両群とも PS の得点に有意な変化がなかったことが示されていた。また、観察データを指標とした事前事後テストデザインと単一事例実験デザインを用いた研究では、標的行動として設定された子どもへの指導スキルや養育行動の改善が示されていた。

子どもへの効果を記述できた研究は 40 件 (78.4%) であった。検査・尺度を指標とした事前事後テストデザインを用いた一部の研究の結果、PT 後に子どもの問題行動、発達障害特性の程度、発達・知的能力、ソーシャルスキルの改善が示されていた。介入群と対照群の群間比較を行った 6 つの研究を見ると、問題行動に関しては、CBCL の総得点が両群とも有意に改善 (松尾・井上, 2013; 免田他, 2015)、両群とも変化なし (Matsuo et al., 2015)、SDQ の総合点が両群とも変化なし (Matsuo et al., 2015; 松尾・井上, 2013; 西嶋他, 2015) という結果が示されていた。免田他 (2015) では、両群とも HSQ の問題状況数に変化は見られなかったものの、平均重篤度については、介入群の、ADHD+ASD 群に有意な改善が認められた。岡島他 (2014) では、介入群の、介入前後の SRS の「対人的コミュニケーション」の得点の変化量が、対照群の変化量と比べて有意に改善したことが示されていた。また、観察データを指標とした事前事後テストデザインと単一事例実験デザインを用いた研究では、多くの子どもに、標的行動として設定された日常生活スキル、対人行動・コミュニケーション、認知・学習、問題行動の改善が見られたが、改善が見られなかった子どもも一部いたことが示されていた。

考 察

本研究の目的は、発達障害のある子どもの親に対する PT に関する国内のエビデンスをアップデートすることであった。2012 年から 2018 年に国内で報告された PT の研究を系統的にレビューし、適格基準を満たした論文 50 本 (研究数 51) について、サンプルサイズ、子どもの特徴、PT プログラムの特徴、効果評価の特徴、効果を分析した。以下に、現在の国内の PT 研究の特徴をまとめ、研究及び研究報告の質という観点から考察し、今後の課題を提示する。

対象論文

本研究で対象となった近年の PT 研究の論文発刊本数は年間平均 7.1 本であった。原口他 (2013) で報告されている直近 7 年間 (2005 年から 2011 年) の論文発刊本数は年間平均 4.1 本であり、近年、PT 研究の論文発刊本数が増加していることが示された。また、本研究の対象論文の半数 (25 本) は査読付きの学会誌に掲載された論文であり、原口他 (2013) の対象論文で査読付きの学会誌に掲載された論文が 4 割 (19 本) であったことを考えると、以前と比べて、近年はより質の高い研究論文が報告されていると思われる。

サンプルサイズと子どもの特徴

本研究の対象となった研究のサンプルサイズは、親 が 10.6 ($SD=10.54$, range 1-48, $n=50$)、子どもが 10.0 ($SD=9.84$, range 1-48, $n=46$) であった。原口他 (2013) の結果 (親のサンプルサイズ: 11.4 ($SD=13.26$, range 1-45, $n=52$); 子どものサンプルサイズ: 9.1 ($SD=10.22$, range 1-36, $n=49$)) と比べて大きな変化はなかった。海外の PT 研究ではサンプルサイズが 100 以上の研究も多数あり (Rimestad et al., 2019; Postorino et al., 2017)、国内の PT 研究のサンプルサイズは海外の研究に比べて依然として小さいと言える。

対象の子どもの年齢に関しては、学童期が 68.6% (35 件) と最も多く、幼児期が 58.8% (30 件)、青年期が 15.7% (8 件) であった。原口他 (2013) の結果 (学童期: 61.7% (29 件); 幼児期:

59.6% (28 件)；青年期：25.5% (12 件))と比べると、学童期や幼児期の割合に大きな違いはなく、青年期の割合がやや少ないことが示された。対象児の診断の有無に関しては、診断のある子どもを対象とした研究が 80.4% (40 件) と大半を占めており、少数であるが確定診断のない子どものみを対象とした研究も 5.9% (3 件) あった。論文に記載された情報から子どもの診断の有無に関して判断できない研究や詳細な記載のない研究も 13.7% (7 件) あった。原口他 (2013) の結果 (診断のある子ども：85.1% (40 件)；診断のない子どものみ：8.5% (4 件)；不明：6.4% (3 件)) と比べると、本研究では子どもの診断の有無に関して不明のものがやや多かった。PT 研究がどのような特徴の子どもを対象として実施されたものなのか、また示された結果はどのような対象児において得られたものなのかを研究論文から正確に理解するためには、対象児の年齢や診断等の特徴に関する詳細な情報が必要不可欠であり、論文への記載が求められる。

PT プログラムの特徴

国内の代表的な PT プログラムである精研式・まめの木式・奈良式、肥前式、鳥取大式、トリプル P の研究は 35.3% (18 件) に留まり、これらのプログラムは、開発の研究において有効性が検証されマニュアル化されたプログラムではあるが、各プログラムの十分な有効性を示すためには研究数が少ないと思われた。今後、多施設での追試研究による検証が必要と思われる。一方、それら以外の、研究機関・実施機関独自のプログラムに関する研究は 64.7% (33 件) あり、プログラムは非常に多様であった。それぞれの研究においてもさらなる追試研究が待たれる。プログラムの実施形態は、集団が 82.4% (42 件) であり、個別 (9 件) に比べて 4.7 倍多かった。原口他 (2013) の結果 (集団：57.4% (27 件)；個別：42.6% (20 件)) と比べて、集団形態の PT の研究が増加し、個別形態の PT の研究は減少していた。セッティングや実施者は多様であったが、未記載であったり記載内容から第三者が判断できなかったりしてその詳細が不明なものがそれぞれ 29.4%、23.5%

あった。また、プログラムの実施の質を確保するためには、PT の実施者への研修や認定、スーパーバイズ、また実行度の評価等が必要になると思われるが、クオリティコントロールに関して記載された研究は 23.5% であり、多くの研究でどのようにして PT の実施の質が確保されているか不明であった。追試研究はもちろん、研究に基づいたプログラムを実践する上でも、プログラムの実施が再現可能となるように、プログラムの内容、セッティング、実施者、クオリティコントロール等に関する情報をできるだけ詳細に記載することが必要である。

本研究の対象となった研究の中には、PT と並行して子どもに対して療育や SST 等の介入が行われた研究が 37.3% (19 件) 含まれていた。PT と子どもへの介入を組み合わせることの臨床的有用性は高いと考えられるが、PT のみの効果なのか、PT と子どもへの介入の効果なのかを検証する上で、子どもに対する介入の有無やその内容について正確に記載することが適切である。

効果評価の特徴

親への効果の評価指標として、客観的な指標である検査・尺度や観察データを用いた研究がそれぞれ 76.5% (39 件)、17.6% (9 件) あり、一方で、効果評価が行われていない研究が 2.0% (1 件) あった。原口他 (2013) の結果 (検査・尺度：40.4% (19 件)、観察データ：10.6% (5 件)、評価なし：19.1% (9 件)) と比べると、PT による親への効果評価がほぼ全ての研究で行われるようになり、特に検査・尺度を用いた研究が増加したことが明らかとなった。具体的には抑うつ・不安・ストレスが最も多く、他にも行動理論の知識、精神健康、セルフエフィカシー、親子関係、養育行動等多様なアウトカムが評価されていた。観察データを用いた研究では、主に子どもへの指導スキルや養育行動が評価されていた。海外の PT 研究でも、親のアウトカムは、ストレス (Oono et al., 2013; Tarver et al., 2019)、メンタルヘルス (Dawson-Squibb, Davids, Harrison, Molony, & de Vries, 2019)、セルフエフィカシー (Dawson-Squibb et al., 2019)、養育行動 (Rimestad et al.,

2019; Weitlauf et al., 2014) 等が評価されており、海外の PT 研究と概ね共通する傾向が見られた。親への効果の評価方法については、事前事後テストデザインが 80.4% (41 件) の研究で用いられており、うち群間比較を実施した研究が 19.6% (10 件) あった。なお、介入群と対象群の比較は 11.8% (6 件) の研究で行われていた。また、単一事例実験デザインが 15.7% (8 件) の研究で用いられていた。さらに、統計解析を行った研究が 52.9% あった。原口他 (2013) の結果 (事前事後テストデザイン: 48.9% (23 件); 群間比較研究: 0; 単一事例実験デザイン: 6.4% (3 件); 統計解析を行った研究: 23.4% (11 件)) と比べると、本研究ではいずれの方法も多くなっており、効果検証により適した研究デザインを用いた研究が近年増加していることが示された。

子どもへの効果の評価指標として、客観的な指標である検査・尺度や観察データを用いた研究がそれぞれ 54.9% (28 件)、29.4% (15 件) あり、一方で、効果評価を行っていない研究が 17.6% (9 件) あった。原口他 (2013) の結果 (検査・尺度: 27.7% (13 件); 観察データ: 36.2% (17 件); 評価なし: 17.0% (8 件)) と比べると、検査・尺度を用いた研究は増加、観察データを用いた研究はやや減少し、効果評価を行っていない研究の割合には変化がなかった。検査・尺度に関しては、問題行動が最も多く、発達障害特性、発達・知的能力、ソーシャルスキル等が評価されていた。観察データに関しては、主に日常生活スキル、対人行動・コミュニケーション、日常生活スキル、認知・学習、問題行動が評価されていた。海外のレビューでも、子どものアウトカムは、問題行動 (Daley et al., 2014; Postorino et al., 2017; Rimestad et al., 2019)、発達障害特性 (Daley et al., 2014; Oono et al., 2013; Rimestad et al., 2019; Weitlauf et al., 2014)、発達 (Dawson-Squibb et al., 2019)、知的能力 (Weitlauf et al., 2014) 等が評価されており、海外の PT 研究と概ね共通する傾向が見られた。子どもへの効果の評価方法については、事前事後テストデザインが 56.9% (29 件) の研究で用いられており、うち群間比較を実施した研究は 19.6% (10 件) あった。なお、介入群

と対象群の比較は 11.8% (6 件) の研究で行われていた。また、単一事例実験デザインが 27.5% (14 件) の研究で用いられていた。さらに、統計解析を行った研究が 39.2% (20 件) あった。原口他 (2013) の結果 (事前事後テストデザイン: 42.6% (20 件); 群間比較研究: 0; 単一事例実験デザイン: 29.8% (14 件); 統計解析を行った研究: 10.6% (5 件)) と比べると、単一事例実験デザインを用いた研究数には変化がなく、事前事後テストデザイン、群間比較研究、統計解析を行った研究は増加しており、子どもに関しても、効果検証により適した研究デザインを用いた研究が近年増加していることが示された。

以上のことから、近年の研究では、より客観的な指標と、より効果検証に適した研究デザインを用いて、親と子どもへの効果を検証する研究が増加していることが明らかとなった。しかしながら、親への効果評価に比べると子どもへの効果評価は少ない傾向にあった。また、親と子ども両方とも、効果の評価指標として標準化された検査・尺度と観察データを併用している研究は少なかった。PT は、親への支援であると同時に、親を介した子どもへの支援でもある。海外の PT は発達障害のある子どもへの支援アプローチの 1 つとして位置づけられることが多く (Hyman, Levy, & Myers, 2020; WHO, n. d.; Wolraich et al., 2019)、子どものアウトカムが重視される傾向がある。一方、我が国の PT は発達障害のある子どもの親への支援アプローチの 1 つとして位置づけられている (厚生労働省, n. d.)。このような背景の違いが、国内外の PT 研究のアウトカムの評価の焦点に影響している可能性がある。つまり、海外では子どものアウトカムが主に評価される傾向にあり、国内では親のアウトカムが主に評価される傾向があるのかもしれない。PT では、親と子ども両方のアウトカムを評価することが必要である。評価に際しては、PT の前後に標準化された検査・尺度を用いることで、参加者集団としての全体のアウトカムの評価が可能となり、同時に、PT の前後及び経過中に観察データも用いることで、参加者親子個々の行動変化の経過もモニタリングすることが可能となるため、検査・尺度と観

察データを併用し、かつ、事前事後テストデザインと単一事例実験デザインを併用することが望まれる。

PTの実行度の結果に関するデータが記載された研究は1件であった。海外のPT研究の系統的レビューによると、実行度に関するデータが報告されていた研究は0(Schultz, Schmidt, & Stichter, 2011)、2割程度(Dawson-Squibb et al., 2019)、7割程度(Garbacz, Brown, Spee, Polo, & Budd, 2014)と結果は一貫していないが、決して高い値とは言えない。PTを忠実に実施するために、また、PTの効果を検証するためにも実行度の評価は必要不可欠であり、我が国のPT研究においても実行度の評価と報告は重要かつ必要であると思われる。また、PTへの参加率やプログラムの評価に関する報告が行われた研究はそれぞれ約半数であった。どちらもPTにおいて重要な評価項目であると思われる、今後の研究で評価および報告されることが期待される。

効果

親への効果に関して、検査・尺度を指標とした事前事後テストデザインを用いた研究では、PTを受けた親の抑うつ・不安・ストレス、精神健康、セルフエフィカシー、行動理論に関する知識、親子関係、養育行動の改善が示されていた。また、観察データを指標とした事前事後テストデザインと単一事例実験デザインを用いた研究では、PTを受けた親の指導スキルや養育行動の改善が示されていた。しかしながら、介入群と対照群の群間比較を行った研究からは、PTによる抑うつ・不安・ストレス、セルフエフィカシー、養育行動の改善は示されなかった。抑うつに関しては、両群とも改善(Matsuo et al., 2015)もしくは変化なし(松尾・井上, 2013; 西嶋他, 2015)という結果であった。ストレスに関しては、介入群の親のストレスの有意な改善が示された研究(岡島他, 2014; 富尾他, 2018)と、変化が見られなかった研究(免田他, 2015)があり、結果は一貫していなかった。なお、岡島他(2014)、富尾他(2018)、免田他(2015)の研究は全て、介入群も対照群も子どもが直接的な介入を受けていること

から、その結果の解釈には注意が必要である。また、西嶋他(2015)でもストレスの改善は示されなかった。セルフエフィカシーに関しては、群間差なし(岡島他, 2014)、養育行動に関しては、両群とも変化なし(西嶋他, 2015)という結果であった。親子関係に関しては、松尾・井上(2013)では、両群とも変化が見られなかったが、Matsuo et al. (2015)では対照群と比べて介入群に改善が見られていた。しかしながら、Matsuo et al. (2015)では、介入前の時点で、評価に使用された尺度の得点が介入群の方が顕著に高く、一方で対照群の得点は低い状態であり、その群間差が変化の仕方に影響している可能性は否定できない。

子どもへの効果に関して、検査・尺度を指標とした事前事後テストデザインを用いた一部の研究では、PTによる子どもの問題行動、発達障害特性の程度、発達・知的能力、ソーシャルスキルの改善が示されていた。観察データを指標とした事前事後テストデザインと単一事例実験デザインを用いた一部の研究では、日常生活スキル、対人行動・コミュニケーション、認知・学習、問題行動の改善が示されていた。しかしながら、介入群と対照群の群間比較を行った研究では、PTによる問題行動、発達障害特性の改善は示されなかった。問題行動に関しては、尺度によって、介入群の一部に有意な改善(免田他, 2015)、両群とも有意に改善(松尾・井上, 2013; 免田他, 2015)、両群とも変化なし(松尾・井上, 2013; Matsuo et al., 2015; 免田他, 2015; 西嶋他, 2015)という結果であった。発達障害特性に関しては、ASD特性の一部に有意な改善が示された(岡島他, 2014)。なお、免田他(2015)と岡島他(2014)では、介入群も対照群も子どもが直接的な介入を受けていることから、その結果の解釈には注意が必要である。

以上のことから、PTは親と子どもの多様なアウトカムの改善に一定の効果をもたらすことが示唆された。研究間の結果の不一致には、個々の研究の、対象の違い、サンプルサイズ、介入群と対照群の特徴(PT以外のなんらかの介入を受けていたこと等)、評価の指標や時期の違い等研究デ

デザイン上の問題が影響している可能性がある。今後、PT の効果を実証するためには、より大きなサンプルサイズで、より厳密な研究デザインを用いた検証が求められる。

限界と課題

本研究の限界を三点示す。第一に、本研究で対象とした PT 研究には多様な PT プログラムが含まれている点である。国内の代表的なプログラムである精研式・まめの木式・奈良式、肥前式、鳥取大式、トリプル P 等、または研究機関や支援機関独自のプログラムがあり、内容、回数、頻度、時間、実施形態、セッティング、実施者等は多様であった。本研究では、それらの多様なプログラムを PT として同等に扱い、分析した結果をまとめた。そのため、本研究で得られた結果の解釈には、この点を考慮する必要がある。特定の PT プログラムの有効性に関しては、該当する PT プログラムに限定した検証が必要である。また、本研究では詳細に分析できていないプログラムの構成内容（個々のセッションの内容や教授方法）に着目した分析を行うことで、PT プログラムの有効な要素を検証できる可能性がある。

第二に、本研究で対象とした PT 研究には多様な特徴の子どもが含まれている点である。本研究では、年齢、障害の種類や程度を限定せず、発達障害のある子どもとして一つにまとめて分析し、結果を示したが、PT の有効性が個々の子どもの特徴によって異なる可能性がある。海外では子どもの年齢や障害種別に PT の有効性が検証されエビデンスが示されており、我が国でも子どもの特徴と PT の有効性との関連を検証する研究の増加が期待される。

第三に、本研究で示した効果の解釈に注意が必要な点である。本研究で示した効果については、個々の研究において肯定的な結果が報告されていたものが多かったが、その大半は、サンプルの少ない一群事前事後テストデザインや単一事例実験

デザインによる研究であったため結果の一般化は困難であること、また、子どもに対する介入が組み合わされている研究では PT のみの効果を明らかにできないこと、群間比較研究が約 1 割あったが対照群と比較して介入群に有意な効果が示されていないことに注意する必要がある。

結語

我が国の発達障害のある子どもの親に対する PT 研究は近年増加しており、多くの研究から、PT を受けた親の抑うつ・不安・ストレス、精神健康、セルフエフィカシー、行動理論に関する知識、養育行動、親子関係、指導スキルの改善が示された。また、PT の対象となった子どもの問題行動、発達障害特性、発達・知的能力、ソーシャルスキル、日常生活スキル、対人・コミュニケーション、認知・学習の改善が示された。以前と比べると PT 研究の質は明らかに高くなってきており、本研究から、PT の効果に関する一定のエビデンスは得られたと言える。しかしながら、我が国の PT 研究には、サンプルサイズが小さい、群間比較研究が少ない、対象やプログラムに関する正確な情報が不足している、実行度、参加率、プログラムの評価の報告が不足している等の課題が依然として多くあることも示された。このことは、今後の研究において、より大きなサンプルサイズで、より厳密な研究デザインを用いて、より質の高いエビデンスを蓄積していく必要があることを意味する。一方で、我が国ではすでに国の施策として PT の普及が推進されているところであるが、国内の PT の効果に関するエビデンスはいまだ十分とは言えない状況であることから、実践されている PT の有効性及び有用性に関する評価と研究を進めていくことも必要不可欠である。

注

- 1) 現所属：鳥取大学

引用文献

本研究の分析対象論文において用いられた検査・尺度等（表4・5）に関する文献は、付録（付録4）に掲載する。

* 本研究における分析対象論文

- Barlow, D. H., & Hersen, M. (1984). *Single case experimental designs: Strategies for studying behavior change* (2nd ed.). New York: Pergamon Press. (高木俊一郎・佐久間徹 (監訳) (1993). 一事例の実験デザイン——ケーススタディの基本と応用—— 二瓶社)
- Daley, D., Oord, S., Ferrin, M., Danckaerts, M., Doepfner, M., Cortese, S., & Sonuga-Barke, E. J. S. (2014). Behavioral interventions in attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analysis of randomized controlled trials across multiple outcome domains. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 53, 835–847.
- Dawson-Squibb, J. J., Davids, E. L., Harrison, A. J., Molony, M. A., & Vries, P. J. (2019). Parent education and training for autism spectrum disorders: Scoping the evidence. *Autism*, 24, 7–25.
- * 藤坂龍司・井上雅彦 (2012). 自閉症早期家庭療育のための集団親指導プログラム 行動療法研究, 38, 57–70.
- * 藤原直子・石井主税・岡田佐和子 (2015). 大学と地域支援機関の連携によるペアレント・トレーニングの実践 吉備国際大学心理・発達総合研究センター紀要, 1, 13–22.
- Garbacz, L. L., Brown, D. M., Spee, G. A., Polo, A. J., & Budd, K. (2014). Establishing treatment fidelity in evidence-based parent training programs for externalizing disorders in children and adolescents. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 17, 230–247.
- 原口英之・上野 茜・丹治敬之・野呂文行 (2013). 我が国における発達障害のある子どもの親に対するペアレント・トレーニングの現状と課題——効果評価の観点から—— 行動分析学研究, 27, 104–127.
- * 平澤紀子 (2015). 発達障害児の保護者を対象としたPBSに基づく学習会の評価 岐阜大学教育学部研究報告 人文科学, 64, 135–141.
- Hyman, S. L., Levy, S. E., & Myers, S. M. (2020). Identification, evaluation, and management of children with autism spectrum disorder. *Pediatrics*, 145, e20193447.
- 一般社団法人日本発達障害ネットワーク JDDnet (2020). 発達障害支援における家族支援プログラムの地域普及に向けたプログラム実施基準策定及び実施ガイドブックの作成に関する調査報告書 令和元年度障害者総合福祉推進事業
- * 石塚誠之・狩野信也 (2017). 発達障害が疑われる幼児の母親に対するビデオフィードバックを活用したペアレント・トレーニングの効果 北翔大学北方圏学術情報センター年報, 9, 11–17.
- * 伊藤信寿・石附智奈美 (2018). ペアレント・トレーニングにおける母親の子どもに対する認識の変化について 作業療法, 37, 57–66.
- * 上村誠也・小野里美帆 (2017). 自閉症スペクトラム障害幼児への「家庭訪問型支援」による発達支援 (1) ——保護者による家庭課題への取り組みとその経過に着目して—— 教育学部紀要, 51, 201–211.
- * 神山 努 (2017). 特別支援学校 (知的障害) における相互ビデオフィードバックを用いた全5回のペアレント・トレーニングの効果 特殊教育学研究, 55, 157–170.
- * 神山 努・澤田智子・岸 明宏 (2016). 通級指導を利用する発達障害児の保護者に対するペアレント・トレーニング——全5回のプログラムの効果—— LD研究, 25, 476–488.
- * 神山 努・竹中正彦 (2016). 自閉スペクトラム症幼児の保護者に対するインターネット電話を介したペアレント・トレーニングの効果 特殊教育学研究, 54, 245–256.
- 厚生労働省 (n. d.). 発達障害者支援施策の概要 Retrieved from https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaisahukushi/hattatsu/gaiyo.html (2020年7月29日)
- * 久保信代・岩坂英巳 (2013). 広汎性発達障害児 (PDD 児) を対象としたペアレント・トレーニング——PDD の特性に応じたプログラムの改変と効果に影響を与える要因について—— 児童青年精神医学とその近接領域, 54, 552–570.
- * 増田裕美・西嶋真理子 (2018). 前向き子育てプログラムに参加した学童期以降の発達障がい児の親の子育てについての認知と行動の変化 日本地域看護学会誌, 21, 49–55.
- * 松田光一郎 (2017). 自閉スペクトラム症児に対する早期集中行動介入 (EIBI) の効果と課題——家庭における親指導の事例をもとに—— 人間福祉学会誌, 17, 23–29.
- * 松尾理沙・井上雅彦 (2013). 思春期の発達障害児を持つ親のためのペアレント・トレーニングプログラムの開発 発達研究, 27, 71–80.
- * Matsuo, R., Inoue, M., & Maegaki, Y. (2015). A comparative evaluation of parent training for parents of adolescents with developmental disorders. *Yonago Acta Medica*, 58, 109–114.
- * 免田 賢 (2015). ADHD に対するスマートリートメントプログラムにおけるペアレントトレーニングの長期効果について 発達障害研究, 37, 247–258.
- * 免田 賢・向笠章子・家村明子・山下裕史朗・松石豊次郎 (2015). ADHD 単独群と ASD 合併群のサマー・トリートメント・プログラムとペアレントトレーニングの効果 小児の精神と神経, 55, 25–38.
- * 宮崎美江・宮崎光明・井上雅彦 (2015). 発達障害のある子どものきょうだい間のトラブルに対するペアレント・トレーニングの効果 小児の精神と神経, 55, 129–142.

- * 水内豊和・阿部美穂子 (2012). 教育相談センターが実施する「気になる子」の保護者に対するペアレント・トレーニングのあり方と効果 LD 研究, 21, 270-284.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLOS Medicine*, 6, e1000097.
- * 百瀬 良・越智眞理子・佐藤昌子・松永しのぶ・藤崎春代 (2014). 地域の発達障害児支援事業における発達相談室の役割——個別発達相談及びペアレント・トレーニングの検討—— 昭和女子大学生活心理研究所紀要, 16, 81-93.
- * 本山和徳・松坂哲應・長岡珠緒・松尾光弘 (2012). 発達障害児の養育に困難感を抱く母親に対するペアレントトレーニングの効果 脳と発達, 44, 289-294.
- * 中山政弘 (2014). 肥前方式ペアレント・トレーニング短縮版開発に関する研究 福岡県立大学心理臨床研究, 6, 111-117.
- * 名越斉子 (2013). 実行可能性と汎用性を備えた発達障害児の保護者支援プログラムの検討 埼玉大学教育学部教育実践総合センター紀要, 12, 75-82.
- * 西嶋眞理子・松浦仁美・星田ゆかり (2015). 発達障害児の親を対象に保健師が行った前向き子育てプログラム (Positive Parenting Program; トリプル P) の評価——評価指標による介入効果の分析—— 日本地域看護学会誌, 18, 41-50.
- * 西嶋眞理子・柴 珠実・齋藤希望・増田裕美・西本絵美・松浦仁美 (2018). 発達障害児の親を対象に行った前向き子育てプログラム (Positive Parenting Program; トリプル P) の効果と地域での導入の検討——ステッピングストーンズ・トリプル P (Stepping Stones Triple P) 実施前後比較より—— 日本地域看護学会誌, 21, 40-49.
- * 野村和代・吉留富子 (2014). 発達障害をとまなう外国籍児童の保護者へのペアレント・トレーニング——プログラム開発とファシリテーター養成研修プログラムの開発—— 研究助成論文集, 50, 20-26.
- * 野津山希・堤 俊彦・嶋崎まゆみ・加藤美朗・井場朱紗美・伊垣知美・澁谷友美 (2012). ペアレント・トレーニングにおける汎用性促進を目指したプログラム——ショートプログラムを用いた効果の検討—— 福山大学こころの健康相談室紀要, 6, 135-143.
- * 野津山希・堤 俊彦・嶋崎まゆみ・加藤美朗・奥本早紀・柿原美佳子・澁谷友美 (2013). 地域におけるペアレント・トレーニングの汎用性促進を目指したプログラムの検討——ピアカウンセリング効果の視点から—— 福山大学こころの健康相談室紀要, 7, 131-139.
- * 荻野昌秀・平 雅夫・安川直史 (2014). 発達に課題のある児についての福祉センターでのペアレントトレーニングのプログラム開発とその効果 自閉症スペクトラム研究, 11, 49-54.
- * 岡島純子・加藤典子・吉富裕子・大谷良子・山本淳一・作田亮一 (2014). 自閉症スペクトラム障害児に対する社会的スキル訓練・親訓練の効果——「獨協なかまプログラム」開発のための予備的研究—— 子どもの心とからだ, 23, 49-57.
- * 岡村章司 (2015). 特別支援学校における自閉症児に対する保護者支援——母親の主体性を促す支援方略の検討—— 特殊教育学研究, 53, 35-45.
- * 奥野裕子・荒木田美香子・永井利三郎・奥野正景 (2012). 精神科訪問看護指導におけるペアレントトレーニングの影響に関する事例検討——注意欠陥／多動性障害 (AD/HD) の子どもをもつ母親への支援—— 発達障害研究, 34, 179-194.
- * 奥野裕子・加藤久美・山本知加・村田絵美・福田祥子・松崎順子・谷池雅子 (2014). 大阪府堺市における4・5歳児発達相談事業後の支援として——短縮型ペアレント・トレーニング (堺市版) の試み—— 小児保健研究, 73, 88-95.
- * 奥野裕子・永井利三郎・毛利育子・吉崎亜里香・山本知加・酒井佐枝子・谷池雅子 (2013). 広汎性発達障害に対するペアレントトレーニング (少人数・短縮型) の有効性に関する研究 脳と発達, 45, 26-32.
- * 大野裕史・半田 健・山本ミカ・秦 裕子・西田晴香・松本将平・高階美和 (2012). 修士課程学生が担当者となった発達障害のある子への親の支援セミナー 発達心理臨床研究, 18, 53-64.
- Oono, I. P., Honey, E. J., & McConachie, H. (2013). Parent-mediated early intervention for young children with autism spectrum disorders (ASD) (Review). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2013, 4.
- Postorino, V., Sharp, W. G., McCracken, C. E., Bearss, K., Burrell, T. L., Evans, A. N., & Scahill, L. (2017). A systematic review and meta-analysis of parent training for disruptive behavior in children with autism spectrum disorder. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 20, 391-402.
- Rimestad, M. L., Lambek, R., Christiansen, H. Z., & Hougaard, E. (2019). Short- and long-term effects of parent training for preschool children with or at risk of ADHD: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Attention Disorders*, 23, 423-434.
- * 坂本美香 (2015). 小児科医によるペアレントトレーニングへの参加報告——作業療法士による実践を目指してのpilot study—— 作業療法, 34, 703-712.
- Schultz, T., Schmidt, C., & Stichter, J. P. (2011). A review of parent education programs for parents of children with autism spectrum disorders. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 26, 96-104.
- * 島田明子・水内豊和 (2016). 保健センターにおける発達に気がかりのある幼児の母親を対象とした「ペアレント・プログラム」の効果に関する実践研究——3歳児検診で要経過観察児とされた時期におこなう集団式の親支

援とは—— とやま発達福祉学年報, 7, 3-10.

- * 杉原聡子・米山直樹 (2014). ビデオ・フィードバックを用いた自閉スペクトラム症のある子どもの親訓練プログラムの効果 人文論究, 64, 59-76.
- * 杉原聡子・米山直樹 (2015). 自閉スペクトラム症児の運筆訓練時における親の指導行動に対するビデオ・フィードバック 行動分析学研究, 30, 13-23.
- * 杉原聡子・米山直樹 (2017). 目標行動選定用シートを用いた短縮版ペアレント・トレーニングの試み 人文論究, 67, 43-60.
- * 杉原聡子・米山直樹 (2018). 目標行動選定用シートを用いた短縮版ペアレント・トレーニングの試み (2) 人文論究, 68, 175-187.
- * 篁 倫子・小嶋美奈子・小林智子・田上友里加 (2017). 発達障害の子どもの母親のエンパワメントと支援——ストレスマネジメントを取り入れたペアレントトレーニングの実践—— お茶の水女子大学心理臨床相談センター紀要, 19, 91-97.
- * 田村典久・森下恵加・杉山雅彦 (2012). 自閉症の児童に対する機能的アセスメントに基づく介入と親指導の効果の検討 自閉症スペクトラム研究, 10, 33-42.
- Tarver, J., Palmer, M., Webb, S., Scott, S., Slonims, V., Simonoff, E., & Charman, T. (2019). Child and parent outcomes following parent interventions for child emotional and behavioral problems in autism spectrum disorders: A systematic review and meta-analysis. *Autism*, 23, 1630-1644.
- * 富尾則子・瀧上達夫・後藤沙羅・笹川 彩・佐藤菜穂・恵良美津子・高橋昌里 (2018). 広汎性発達障害児に対するソーシャルスキルトレーニングとその保護者に対するペアレントトレーニングによる効果の検討 子どもの心とからだ, 27, 24-32.
- * 富澤弥生・佐藤利憲・横山浩之 (2013). 高機能広汎性発達障害へのペアレントトレーニング及び注意欠陥／多動性障害への併存診断の有用性についての考察 脳と発達, 45, 33-37.
- * 津田芳見・田中美沙・高原光恵・橋本俊顕 (2012). 高機能広汎性発達障害幼児とその親へのペアレントトレーニングによる効果の検討 小児保健研究, 71, 17-23.
- * 常田秀子 (2015). 発達に軽微な偏りがある3歳児の親子に対するペアレントトレーニングの有効性 和光大学現代人間学部紀要, 8, 157-167.
- * 上野 茜・野呂文行 (2012). 自閉症障害児の母親に対するビデオフィードバックとチェックリストを用いた介入の効果 障害科学研究, 36, 69-80.
- * 上野 茜・高浜浩二・野呂文行 (2012). 発達障害児の親に対する相互ビデオフィードバックを用いたペアレントトレーニングの検討 特殊教育学研究, 50, 289-304.
- Weitlauf, A. S., McPheeters, M. L., Peters, B., Sathe, N., Travis, R., Aiello, R., ... & Warren, Z. (2014). Therapies for children with autism spectrum disorder: Behavioral interventions update. *AHRQ Comparative Effectiveness Review*, No. 137.
- Wolraich, M. L., Hagan, J. F., Allan, C., Chan, E., Davison, D., Earls, M., ... & Zurhellen, W. (2019). Clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. *Pediatrics*, 144, e20192528.
- World Health Organization (n. d.). Training parents to transform children's lives. Retrieved from https://www.who.int/mental_health/maternal-child/PST/en/ (2020年7月24日)
- * 安井梨恵・米山直樹 (2018). 小規模市町村における有効な早期発達支援の在り方についての検討——保健センターにおける短縮版ペアレント・トレーニングの実践を通して—— 関西学院大学心理科学研究, 44, 17-22.
- * 米倉裕希子・堤 俊彦・金平 希・岡崎美里 (2014). 発達障害児のペアレントトレーニングの有効性に関する研究——家族の感情表出とペアレントトレーニング—— 関西福祉大学社会福祉学部研究紀要, 17, 17-22.

——2020.9.11. 受稿、2020.11.24. 受理——

付録1 対象者及びPTプログラムの特徴

著者（年）	サンプルサイズ （親）	サンプルサイズ （子ども）	子どもの年齢	子どもの診断	PTプログラム	実施形態	セッティング	実施者	クオリティ コントロール	子どもへの 介入
伊藤・石附（2018）	15	15	幼児期・学童期 平均8.3歳（5～12歳）	診断ありのみ ADHD、ASD	精研・まめの木・奈良 式を参考 週1、10回	集団	不明	作業療法士	—	—
増田・西嶋（2018）	6	6	学童期・青年期 平均10.5歳（8～15歳）	一部診断あり ASD、AS、ADHD等	トリプルP 週1、8回	集団＋個別	不明	その他	有	—
西嶋他（2018）	32（分析対象27）	27	幼児期・学童期 平均7.67±2.43歳（3～12歳）	一部診断あり PDD、ASD、ADHD、 DCD等	トリプルP 週1、9回	集団＋個別	不明	その他	有	—
杉原・米山（2018）	9	9	幼児期・学童期 3歳10ヵ月～11歳1ヵ月	診断ありのみ ADHD、PDD＋ADHD、 ASD、PDD	肥前式を参考 月2～3、6回、フ ローアアップ	集団	不明	心理士、その他	—	有
富尾他（2018）	12（PT群＝7、Non- PT群＝5）	12（PT群＝7、Non- PT群＝5）	幼児期 2歳7ヵ月～5歳9ヵ月	一部診断あり PDD	精研・まめの木・奈良 式 月1、10回	集団	医療機関	医師、心理士	—	有
安井・米山（2018） ①	5	5	幼児期	不明	その他 6回／6ヵ月	集団	保健センター	心理士	有	有
安井・米山（2018） ②	5	5	幼児期	不明	その他 6回／6ヵ月	集団	保健センター	心理士	有	有
石塚・狩野（2017）	1	1	幼児期 4歳2ヵ月	診断なしのみ	その他 週1、6回	個別	福祉機関	その他	—	有
上村・小野里 （2017）	1	1	幼児期 4歳7ヵ月	診断ありのみ ASD	その他 月1、1年2ヵ月	個別	家庭	不明	—	有
神山（2017）	3	3	学童期 7歳3ヵ月～7歳4ヵ月	診断ありのみ ASD等	その他 隔週1、5回	集団	学校	学校教員	—	—
松田（2017）	2	2	幼児期 2歳3ヵ月、3歳0ヵ月	診断ありのみ ASD	その他 月1～2、2～3年	個別	福祉機関	その他	—	有
杉原・米山（2017）	6	6	幼児期・学童期 平均6.2歳（4歳10ヵ 月～8歳9ヵ月）	一部診断あり ASD、PDD	肥前式を参考 月2～3、6回、フ ローアアップ	集団	不明	心理士、その他	—	有
篁・小嶋・小林・ 田上（2017）	18（PT群＝6、PT＋ SST群＝12）	19（PT群＝7、PT＋ SST群＝12）	学童期 平均9.0歳、平均9.5歳、 平均9.2歳（小3～小5）	診断ありのみ ASD、LD、ADHD等	精研・まめの木・奈良 式を参考 隔週1、5～7回	集団	大学	心理士、その他	—	有
神山・澤田・岸 （2016）	11	10	学童期・青年期 平均10歳7ヵ月（6歳 5ヵ月～14歳10ヵ月）	一部診断あり ASD、PDD、ADHD	その他 隔週1、5回、フ ローアアップ	集団	学校	不明	有	—

付録1 (続き)

著者 (年)	サンプルサイズ (親)	サンプルサイズ (子ども)	子どもの年齢	子どもの診断	PT プログラム	実施形態	セッティング	実施者	クオリティ コントロール	子どもへの 介入
神山・竹中 (2016)	7	7	幼児期 平均4歳3ヵ月 (3歳 8ヵ月～4歳9ヵ月)	診断ありのみ ASD	その他 隔週1、4回	集団	その他	不明	—	—
島田・水内 (2016)	6 (分析対象2)	6	幼児期 1歳7ヵ月～4歳5ヵ月	診断なしのみ	その他 隔週1、5回	集団	保健センター	保健師、その他	—	—
藤原・石井・岡田 (2015)	11	記載なし	幼児期 平均4歳10ヵ月	不明	鳥取大学を参考 6回/3ヶ月	集団	大学	その他	—	有
平澤 (2015)	14	14	幼児期・学童期・青年 期 幼稚園～高3	診断ありのみ Autism、PDD、AS	その他 5回/8ヶ月	集団	大学	心理士、学校教 員	—	—
Matsuo, Inoue, & Maegaki (2015)	44 (介入群=24、対 照群=20)	記載なし	学童期・青年期 10.8～17.2歳	診断ありのみ ASD、ADHD、LD	その他 6回/3ヶ月	集団	不明	心理士	—	—
免田 (2015)	17	15 (PT 初回のみ群 = 8、PT2 回参加群 = 7)	学童期 平均 8.80 ± 1.22 歳	診断ありのみ ADHD、ADHD + ASD、ADHD + LD	その他 5日間連続	集団	大学、学校	医師、心理士、 学校教員	—	有
免田・向笠・家 村・山下・松石 (2015)	48 (ADHD 単独・STP +PT 群=20、ADHD 単独・STP のみ群=9、 ASD 併 存・STP+PT ASD 併 存・STP+PT 群=13、ASD 併 存・ STP のみ群=6)	48 (ADHD 単独・STP +PT 群=20、ADHD 単独・STP のみ群=9、 ASD 併 存・STP+PT ASD 併 存・STP+PT 群=13、ASD 併 存・ STP のみ群=6)	学童期 平均 9.23 ± 1.45 歳	診断ありのみ ADHD、ADHD + ASD	その他 5日間連続	集団	大学、学校	医師、心理士、 学校教員	—	有
宮崎・宮崎・井上 (2015)	3	8	学童期・青年期 小1～高2	一部診断あり AS、ADHD、PDD、 Autism	その他 4回/2ヶ月	集団	大学	その他	有	—
西嶋・松浦・星田 (2015)	12 (分析対象10: 介 入群=5、対照群=5)	12 (分析対象10: 介 入群=5、対照群=5)	学童期 平均 8.4 ± 1.67 歳、平 均 7.8 ± 3.63 歳	一部診断あり PDD、ASD、ADHD	トリプル P 週1、8回	集団 + 個別	不明	保健師、その他	有	—
岡村 (2015)	1	1	学童期 小6	診断ありのみ Autism	その他 18回/10ヶ月	個別	学校	学校教員	—	有
坂本 (2015)	5	4	学童期 小1～小4	一部診断あり ADHD、PDD	精研・まめの木・奈良 式 隔週1、10回	集団	医療機関	医師、作業療法 士	—	—
杉原・米山 (2015)	1	2 (双子)	幼児期 6歳5ヵ月	診断ありのみ ID + PDD	その他 隔週1、6回	個別	大学	不明	—	有
常田 (2015)	2	2	幼児期 3歳5ヵ月	診断なしのみ	精研・まめの木・奈良 式を参考 隔週1、7回	集団	大学	不明	—	—

付録 1 (続き)

著者 (年)	サンプルサイズ (親)	サンプルサイズ (子ども)	子どもの年齢	子どもの診断	PT プログラム	実施形態	セッティング	実施者	クオリティ コントロール	子どもへの 介入
百瀬・越智・佐藤・松永・藤崎 (2014)	25	23	幼児期・学童期 幼児・小学生	不明	精研・まめの木・奈良式を参考 6回/5~6ヶ月、フォローアップ	集団	大学	心理士	—	—
中山 (2014)	13	9	幼児期 平均 4.3 歳 (3~6 歳)	一部診断あり 不明	肥前式を参考 隔週 1、6 回	集団	不明	不明	—	—
野村・吉留 (2014)	9 (分析対象 5)	記載なし	幼児期 平均 4.2 歳 (3~6 歳 5 ヶ月)	不明	その他 隔週 1、4 回	集団	その他	不明	—	—
荻野・平・安川 (2014)	6	記載なし	学童期 小学生	不明	その他 10 回	集団 + 個別	福祉機関	不明	—	—
岡島他 (2014)	13 (分析対象 12: 介入群 = 6、対照群 = 6)	13 (分析対象 12: 介入群 = 6、対照群 = 6)	学童期 平均 9.0 ± 0.89 歳、平均 8.0 ± 0.89 歳 (小 2 ~ 小 5)	診断ありのみ PDD 等	その他 隔週 1、13 回 (うち PT6 回)	集団	医療機関	心理士	有	有
奥野他 (2014)	11	11	幼児期 平均 4.6 ± 0.5 歳 (4.1 ~ 5.7 歳)	一部診断あり ASD、ADHD、MR	その他 週 ~ 隔週 1、4 回	集団	不明	その他	有	—
杉原・米山 (2014)	2	2	幼児期・学童期 3 歳 4 ヶ月、6 歳 3 ヶ月	一部診断あり Autism	その他 隔週 1、7 回、フォローアップ	個別	大学	不明	—	1 名のみ 有
米倉・堤・金平・岡崎 (2014)	4	4	学童期 10~12 歳 (小 5 ~ 中 1)	不明	その他 隔週 1、5 回	集団	大学	不明	—	—
久保・岩坂 (2013)	20	20	学童期 平均 9 歳 3 ヶ月 (6 歳 11 ヶ月 ~ 12 歳 0 ヶ月)	一部診断あり PDD、PDD + ADHD、PDD + LD 等	精研・まめの木・奈良式を参考 週 1、8 週間、フォローアップ	集団	大学、その他	その他	—	—
松尾・井上 (2013)	10 (介入群 = 5、対照群 = 5)	記載なし	学童期・青年期 10 代	診断ありのみ 不明	その他 隔週 1、7 回	集団	大学	学校教員、その他	有	—
名越 (2013)	4 (分析対象 2)	4 (分析対象 2)	学童期 小 5	診断ありのみ AS 等	その他 隔週 1、6 回	集団 + 個別	不明	不明	—	有
野津山他 (2013)	3	3	学童期 平均 10 歳 (9 ~ 11 歳)	診断ありのみ Autism、HEA	その他 隔週 1、4 回、フォローアップ	集団	その他	心理士、その他	—	—
奥野他 (2013)	33 (分析対象 30: PDD 群 = 8、PDD + ADHD 群 = 16、自閉性障害群 = 6)	30 (PDD 群 = 8、PDD + ADHD 群 = 16、自閉性障害群 = 6)	幼児期・学童期 平均 6.9 ± 1.5 歳 (4.2 ~ 9.6 歳)	診断ありのみ PDD、PDD + ADHD、AD 等	その他 週 ~ 隔週 1、6 回	集団	不明	不明	—	—

付録1 (続き)

著者 (年)	サンプルサイズ (親)	サンプルサイズ (子ども)	子どもの年齢	子どもの診断	PT プログラム	実施形態	セッティング	実施者	クオリティ コントロール	子どもへの 介入
富澤・佐藤・横山 (2013)	不明 (HFPDD + ADHD 群 = 16、 ADHD 群未記載)	32 (HFPDD + ADHD 群 = 16、ADHD 群 = 16)	幼児期・学童期 平均 8.4 ± 3.9 歳、平均 8.2 ± 3.0 歳	診断ありのみ HFPDD + ADHD、 ADHD	その他 10 回	集団	不明	不明	—	—
藤坂・井上 (2012)	13 (分析対象 11)	11	幼児期 平均 37.4 カ月 ($23 \sim$ 60 カ月)	一部診断あり Autism、PDD	その他 週 1~2、6 回、フォ ローアアップ	集団	不明	その他	—	—
水内・阿部 (2012)	12 (分析対象 8)	8	学童期 小 2~小 6	一部診断あり ADHD、ASD、HFA	精研・まめの木・奈良 式を参考 隔週 1、4 回、フォ ローアアップ	集団 + 個別	その他	その他	—	—
本山・松坂・長 岡・松尾 (2012)	24	24	幼児期・学童期・青年 期 平均 8.5 ± 3.5 歳 ($4 \sim$ 13 歳)	診断ありのみ ADHD、PDD、AS 等	精研・まめの木・奈良 式 隔週 1、10 回	集団	不明	医師、心理士	有	15 名のみ有
野津山他 (2012)	7 (分析対象 6)	6	幼児期・学童期・青年 期 $5 \sim 14$ 歳	一部診断あり ASD、ADHD	その他 隔週 1、5 回	集団	その他	その他	—	—
奥野・荒木田・永 井・奥野 (2012)	2	2	学童期 7.9 歳、11.9 歳	診断ありのみ ADHD	精研・まめの木・奈良 式を参考 6 回 / 10 ヶ月	個別	家庭	看護師	—	—
大野他 (2012)	5	5	幼児期・学童期 5 歳 1 カ月~10 歳 6 カ 月	診断ありのみ Autism、ID	その他 隔週 1、6 回	集団	不明	その他	有	—
田村・森下・杉山 (2012)	2	1	学童期 小 5	診断ありのみ Autism	その他 週 1、11 回	個別	家庭	その他	—	有
津田・田中・高 原・橋本 (2012)	8	8	幼児期 平均 5 歳 6 カ月 (3 歳 8 カ月~6 歳 7 カ月)	診断ありのみ HFPDD	精研・まめの木・奈良 式を参考 週~隔週 1、8 回、 フォローアアップ	集団	医療機関	医師、その他	有	—
上野・野呂 (2012)	2	2	幼児期・学童期 5 歳 10 カ月、11 歳 11 カ月	診断ありのみ AD	その他 週 1、12~19 週間	個別	大学	その他	—	有
上野・高浜・野呂 (2012)	6	4	幼児期・学童期 年長~小 3	一部診断あり PDD、LD	その他 月 1、10 回	集団	その他	その他	—	—

ADHD = 注意欠如・多動症, ASD = 自閉スペクトラム症, AS = アスペルガー症候群, DCD = 発達性協調運動症, PDD = 広汎性発達障害, LD = 限局性学習症, ID = 知的能力障害, MR = 精神発達遅滞, HFA = 高機能自閉症, AD = 自閉性障害, HFPDD = 高機能広汎性発達障害

付録2 PTプログラムの効果評価の特徴と効果

著者（年）	効果（親）	効果（子ども）	実行度	参加率	プログラムの評価
	評価指標	評価方法	主要な結果	評価指標	評価方法
伊藤・石附（2018）	検査・尺度（KBAPAC、PSI、TK式）	事前事後	・KBAPAC：有意に上昇 ・PSI：「子どもの側面」7因子中4因子、「親の側面」7因子中1因子が有意に減少 ・TK式：10領域中4領域が有意に上昇	検査・尺度（COPM、ADHD-RS）	事前事後
増田・西嶋（2018）	その他	その他	N/A	無	無
西嶋他（2018）	検査・尺度（PS、DASS、PES）	事前事後	・PS：「過剰反応」と「多弁さ」が有意に減少 ・DASS：「抑うつ」と「ストレス」が有意に減少 ・PES：11項目中6項目が有意な上昇	検査・尺度（SDQ）	事前事後
杉原・米山（2018）	検査・尺度（KBAPAC、QRS、GHQ30）	事前事後	・KBAPAC：9名中8名が上昇 ・QRS：9名中4名が減少、1名が上昇 ・GHQ：9名中3名が減少または低得点を維持、6名が上昇	無	無
富尾他（2018）	検査・尺度（PSI）	事前事後（群間比較）	・PSI：PT群の総得点、「子どもの側面」が有意に減少、「親の側面」有意な変化なし、Non-PT群は有意な変化なし ・GHQ：減少	検査・尺度（田中ビネー知能検査、WISC-III、WISC-IV）	事前事後（群間比較）
安井・米山（2018）①	検査・尺度（GHQ-12）、その他	事前事後	・STAI：「状態不安」と「特性不安」が減少 ・KBAPAC：3名中1名上昇、2名減少	検査・尺度（HSQ）	事前事後
安井・米山（2018）②	検査・尺度（新版STAI、KBAPAC）	事前事後	・KBAPAC：3名中1名上昇、2名減少	無	無
石塚・菊野（2017）	観察データ（一致率）、その他	事前事後、単一事例	・観察データ（養育行動）：子どもへの「目録」と「応答」の生起率上昇	検査・尺度（SDQ）、観察データ（一致率）	事前事後、単一事例
上村・小野里（2017）	その他	その他	N/A	検査・尺度（SCERTSプロファイル）、その他	事前事後、その他
神山（2017）	その他	その他	N/A	観察データ	単一事例
松田（2017）	無	無	N/A	検査・尺度（新版K式発達検査、CARS）	事前事後
杉原・米山（2017）	検査・尺度（KBAPAC、QRS、GHQ-30）	事前事後	・KBAPAC：有意に上昇 ・QRS：有意に減少 ・GHQ：有意な変化なし	観察データ	単一事例

付録2 (続き)

著者 (年)	効果 (親)	効果 (子ども)	実行度	参加率	プログラムの評価
	評価指標	評価方法	主要な結果	評価指標	評価方法
鯉・小嶋・小林・田上 (2017)	検査・尺度 (育児負担感、FES)	事前事後 (群間比較)	・育児負担感：全体の「否定的感情の認知」が有意に減少 ・FES：有意に上昇	検査・尺度 (家庭における社会的スキル尺度)	事前事後 (群間比較)
神山・澤田 (2016)	検査・尺度 (新版 STAI、KBPA(C)、その他)	事前事後、その他	・STAI：「状態不安」と「特性不安」が有意に減少 ・KBPA(C)：有意な変化なし ・GHQ：有意な変化なし	観察データ	単一事例
神山・竹中 (2016)	検査・尺度 (GHQ-30)、その他	事前事後	・GHQ：有意な変化なし	観察データ	単一事例
島田・水内 (2016)	検査・尺度 (育児不安尺度、CDQ)	事前事後	・育児不安尺度：2名の「否定的育児感情」が減少、2名中1名の「中核的育児不安」が減少、2名の「育児多忙感」が上昇 ・CDQ：2名中1名が上昇	無	無
藤原・石井・岡田 (2015)	検査・尺度 (QRS、BDI-II)	事前事後	・QRS：有意な変化なし、4因子中1因子のみ有意な減少 ・BDI：有意に減少	検査・尺度 (SDQ)	事前事後
平澤 (2015)	その他	その他	N/A	無	無
Matsuo, Inoue, & Maegaki (2015)	検査・尺度 (CBQ、BDI-II)	事前事後 (群間比較)	・CBQ：交互作用、時期の主効果、群の主効果が有意 ・BDI：交互作用は有意ではなく、時期の主効果のみ有意	検査・尺度 (SDQ、CBCL)	事前事後 (群間比較)
免田 (2015)	検査・尺度 (QRS)	事前事後 (群間比較)	・QRS：PT2回参加群は有意に減少、PT初回のみ群は有意な変化なし	検査・尺度 (CBCL、HSQ)	事前事後 (群間比較)
免田・向笠・家村・山下・松石 (2015)	検査・尺度 (QRS)	事前事後 (群間比較)	・QRS：4群とも有意な変化なし	検査・尺度 (CBCL、HSQ)	事前事後 (群間比較)

付録 2 (続き)

著者 (年)	効果 (親)		効果 (子ども)		実行度	参加率	プログラムの評価
	評価指標	評価方法	主要な結果	評価指標	評価方法	主要な結果	
宮崎・宮崎・井上 (2015)	検査・尺度 (BDI-II)	事前事後 (群間比較)	・BDI：全参加者が減少	観察データ	単一事例	・標的行動 (問題行動)：全参加者の「きょうだいのトラブル」の生起数が減少	—
西嶋・松浦・星田 (2015)	検査・尺度 (PS、DASS、PES)	事前事後 (群間比較)	・PS：介入群と対照群の前後比較では両群とも有意な変化なし ・DASS：介入群と対照群の前後比較では両群とも有意な変化なし ・PES：介入群と対照群の前後比較では両群とも有意な変化なし	検査・尺度 (SDQ)	事前事後 (群間比較)	・SDQ：介入群と対照群の前後比較では両群とも有意な変化なし	有
岡村 (2015)	観察データ	単一事例	・標的行動 (指導スキル)：「指導」と「記録」を継続	観察データ	単一事例	・標的行動 (対人行動・コミュニケーション、日常生活スキル)：「要求言語行動」、「身体洗い」の自発率が上昇	—
坂本 (2015)	検査・尺度 (CDQ)	事前事後	・CDQ：上昇	検査・尺度 (ADHD-RS)	事前事後	・ADHD-RS：合計、「不注意」、「多動性・衝動性」が減少	N/A
杉原・米山 (2015)	観察データ (一一致率)	単一事例	・標的行動 (指導スキル)：「運筆課題の指導行動の正確率」上昇	観察データ (一一致率)	単一事例	・標的行動 (認知・学習)：「運筆逸脱率」減少	有
常田 (2015)	観察データ (一一致率)	事前事後	・標的行動 (養育行動)：「要求・指示」が減少、「協同・共感」が増加	観察データ (一一致率)	事前事後	・標的行動 (対人行動・コミュニケーション)：「発話数」に大きな変化なし	—
百瀬・越智・佐藤・松永・藤崎 (2014)	検査・尺度 (養育スタイル尺度、育児感情尺度、育児感情尺度、その他)	事前事後	・養育スタイル尺度：「肯定的働きかけ」、「叱責」、「相談・つきそい」、「対応の難しさ」、「育てにくさ」が有意に改善 ・育児感情尺度：「肯定感情」、「否定感情」が有意に改善	無	無	N/A	有
中山 (2014)	検査・尺度 (KBPAC、BDI-II、QRS)	事前事後	・KBPAC：有意に上昇 ・BDI：有意な変化なし ・QRS：有意な変化なし	無	無	N/A	有
野村・吉留 (2014)	検査・尺度 (BDI-II)	事前事後	・BDI：有意に減少	検査・尺度 (SDQ)	事前事後	・SDQ：有意な変化なし	有
荻野・平・安川 (2014)	検査・尺度 (KBPAC、QRS、BDI-II)	事前事後	・KBPAC：上昇 (効果量大) ・QRS：減少 (効果量中) ・BDI：減少 (効果量中)	検査・尺度 (ADHD-RS)	事前事後	ADHD-RS：減少 (効果量中)	—
岡島他 (2014)	検査・尺度 (SRS-18、PSES)	事前事後 (群間比較)	・SRS-18：総得点の変化量が、介入群の方が有意に大きい ・PSES：群間の有意差なし	検査・尺度 (SRS)	事前事後 (群間比較)	・SRS：「対人コミュニケーション」の変化量が、介入群の方が有意に大きい	有
奥野他 (2014)	検査・尺度 (CDQ)	事前事後	・CDQ：総得点、17項目中15項目が有意に上昇	無	無	N/A	有

付録2 (続き)

著者 (年)	効果 (親)	効果 (子ども)	評価方法				参加率	プログラムの評価
			評価指標	評価方法	評価指標	評価方法		
杉原・米山 (2014)	検査・尺度 (QRS、障害児育児ストレス認知尺度、BDI-II、KBAPAC)、観察データ (一致率)	・QRS: 1名が減少 ・障害児育児ストレス認知尺度: 2名が減少 ・BDI: 2名が減少 ・KBAPAC: 2名が減少 ・「指導スキル」の実施率が上昇、1名の「ポジティブな働きかけ」の生起率が上昇	事前事後、単一事例	事前事後	観察データ (一致率)	単一事例	—	有
米倉・堤・金平・岡崎 (2014)	検査・尺度 (FAS、GHQ-30、KBAPAC)	・FAS: 変化なし ・GHQ: 変化なし ・KBAPAC: 上昇	事前事後	事前事後	検査・尺度 (CBCL)	事前事後	—	—
久保・岩坂 (2013)	検査・尺度 (TK式、CDQ、GHQ-30)	・TK式: 10項目中9項目が有意に上昇 ・CDQ: 総得点が有意に上昇 ・GHQ: 総得点が有意に減少、「一般的疾患傾向」と「不安と気分変動」が有意に減少	事前事後	事前事後	検査・尺度 (CBCL、ソーシャルスキル尺度)	事前事後	有	—
松尾・井上 (2013)	検査・尺度 (CBQ、BDI-II)、その他	・CBQ: 交互作用、時期の主効果、群の主効果は有意ではない ・BDI: 交互作用、時期の主効果、群の主効果は有意ではない	事前事後 (群間比較)、事後	事前事後 (群間比較)	検査・尺度 (SDQ、CBCL)	事前事後 (群間比較)	—	有
名越 (2013)	その他	N/A	その他	事前事後、その他	検査・尺度 (旭出式社会適応スキル検査)、その他	事前事後、その他	有	有
野津山他 (2013)	検査・尺度 (KBAPAC、GHQ-30)、その他	・KBAPAC: 全参加者が上昇 ・GHQ: 変化なし	事前事後、その他	事後	その他	事後	—	—
奥野他 (2013)	検査・尺度 (CDQ)、その他	・CDQ: 3群とも有意に上昇	事前事後 (群間比較)、その他	事前事後 (群間比較)	検査・尺度 (CBCL)	事前事後 (群間比較)	有	—
富澤・佐藤・横山 (2013)	検査・尺度 (SUBI)	・SUBI: HFPPD+AD/HD 群は「心の健康度」「心の疲労度」の有意な変化なし、AD/HD 群は「心の健康度」「心の疲労度」が有意に改善	事前事後 (群間比較)	事前事後 (群間比較)	検査・尺度 (HSQ)	事前事後 (群間比較)	—	—

付録 2 (続き)

著者 (年)	効果 (親)		効果 (子ども)		実行度	参加率	プログラムの評価
	評価指標	評価方法	主要な結果	評価指標	評価方法	主要な結果	
藤坂・井上 (2012)	検査・尺度 (KBAPAC、GHQ30)、観察データ (一致率)	事前事後、単一事例	・ KBAPAC：上昇 ・ GHQ：10 名中 6 名が改善 ・ 標的行動 (指導スキル)：11 名中 10 名の「教育技法の習得度」が上昇	検査・尺度 (KIDS)、観察データ (一致率)	事前事後、単一事例	・ KIDS：発達指数の上昇 ・ 標的行動 (対人行動・コミュニケーション、認知・学習)：11 名中 10 名の「課題の達成率」上昇	有
水内・阿部 (2012)	検査・尺度 (KBAPAC、FDT 親子関係診断検査)	事前事後	・ KBAPAC：有意に上昇 ・ FDT：7 下位尺度中「無関心」、「養育不安」、「夫婦間不一致」が有意に減少、「基本的受容」が有意に上昇	検査・尺度 (CBCL)	事前事後	・ CBCL：「不安・抑うつ」有意に減少	有
本山・松坂・長岡・松尾 (2012)	検査・尺度 (BDI-II、CDQ)	事前事後	・ BDI：有意に減少 ・ CDQ：有意に上昇	検査・尺度 (CBCL)、その他	事前事後、事後	・ CBCL：「外向尺度」が有意に減少、「ひきこもり」、「身体的訴え」、「攻撃的行動」が有意に減少	有
野津山他 (2012)	検査・尺度 (KBAPAC、GHQ-30)、その他	事前事後、その他	・ KBAPAC：有意に変化なし ・ GHQ：2 名中 1 名の総得点が減少	その他	その他	N/A	有
奥野・荒木田・永井・奥野 (2012)	検査・尺度 (GHQ-28、SE-III 式)、その他	事前事後、その他	・ SE-III：顕著な変化なし ・ GHQ：有意な変化なし	無	無	N/A	有
大野他 (2012)	検査・尺度 (GHQ-30)	事前事後	・ GHQ：有意な変化なし	検査・尺度 (CBCL)、観察データ、その他	事前事後、事後、単一事例	・ CBCL：有意な変化なし ・ 標的行動 (日常生活スキル)：全参加者の「標的行動の達成度」が上昇	有
田村・森下・杉山 (2012)	観察データ (一致率)	単一事例	標的行動 (指導スキル、養育行動)：「指導手続きの使用頻度」の上昇、「本見 - 親間の相互作用の生起率」が上昇	観察データ (一致率)	単一事例	・ 標的行動 (問題行動)：「迷惑行動の生起頻度」が減少	N/A
津田・田中・高原・橋本 (2012)	検査・尺度 (PS-SF、PSAM、KBAPAC)	事前事後	・ PS-SF：有意に減少 ・ PSAM：有意に上昇 ・ KBAPAC：有意に上昇	検査・尺度 (CBCL)	事前事後	・ CBCL：総得点、「内向尺度」と「外向尺度」が有意に減少	有
上野・野呂 (2012)	観察データ (一致率)	単一事例	・ 標的行動 (指導スキル)：「適切行動 (プロンプト・強化) の生起率」が上昇	観察データ (一致率)	単一事例	・ 標的行動 (日常生活スキル)：「着替えの自立達成率」が上昇	N/A
上野・高浜・野呂 (2012)	検査・尺度 (KBAPAC、新版 STAI)、観察データ (一致率)、その他	事前事後、単一事例、その他	・ KBAPAC：5 名が上昇 ・ STAI：2 名の「状態不安」が減少 ・ 標的行動 (指導スキル)：4 名の「適切行動 (強化・プロンプト・環境調整) の生起率」が上昇	観察データ (一致率)	単一事例	・ 標的行動 (日常生活スキル、認知・学習)：「目標行動の達成度」が上昇	有

付録3 親及び子どもへの効果の評価指標の組み合わせ

	効果評価指標（子ども）								合計
	検査・尺度 のみ	検査・尺度 + 観察デー タ	検査・尺度 + 観察デー タ + その他	検査・尺度 + その他	観察デー タのみ	観察デー タ + その他	その他のみ	なし	
効果評価指標（親）									
検査・尺度のみ	18	0	1	1	2	0	0	5	27
検査・尺度 + 観察データ	0	1	0	0	1	0	0	0	2
検査・尺度 + 観察データ + その他	0	0	0	0	1	0	0	0	1
検査・尺度 + その他	3	0	0	0	2	0	2	2	9
観察データのみ	0	0	0	0	5	0	0	0	5
観察データ + その他	0	1	0	0	0	0	0	0	1
その他のみ	0	0	0	2	1	0	0	2	5
なし	1	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	22	2	1	3	12	0	2	9	51

付録4 本研究の分析対象論文において使用された検査・尺度等に関する文献

- Altepeter, T. S., & Breen, M. J. (1989). The Home Situations Questionnaire (HSQ) and the School Situations Questionnaire (SSQ): Normative data and an evaluation of psychometric properties. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 7, 312-322.
- Arnold, D. S., O'Leary, S. G., & Acker, M. M. (1993). The Parenting Scale: A measure of dysfunctional parenting in discipline situations. *Psychological Assessment*, 5, 137-144.
- 旭学園教育研究所, 肥田野直 (監修) (2012). ASA 旭出式社会適応スキル検査手引 日本文化科学社
- 東 洋・柏木恵子・繁多 進・唐澤真弓 (2002). FDT 親子関係診断検査——手引き—— 日本文化科学社
- Constantino, J. N., & Gruber, C. P. (2005). *The Social Responsiveness Scale (SRS) manual*. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
- Coopersmith, S. (1967). *The antecedents of self-esteem*. San Francisco, CA: Freeman.
- Fujita, H., Shimodera, S., Izumoto, Y., Tanaka, S., Kii, M., Mino, Y., & Inoue, S. (2002). Family Attitude Scale: Measurement of criticism in the relatives of patients with schizophrenia in Japan. *Psychiatry Research*, 110, 273-280.
- Goldberg, D. (1978). *Manual of the General Health Questionnaire*. Windsor, UK: NFER-Nelson.
- Goodman, R. (1999). The extended version of the Strengths and Difficulties Questionnaire as a guide to child psychiatric caseness and consequent burden. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 40, 791-799.
- 肥田野直・福原真知子・岩脇三良・曾我祥子・Spielberger, C. D. (2000). 新版 STAI マニュアル 実務教育出版
- 保坂 明・池田千代子 (1980). いわゆる情緒障害児の親子関係に関する一研究 (KBPA を使って) 自閉児教育研究, 3, 19-28.
- 井淵知美・上林靖子・中田洋二郎・北 道子・藤井浩子・倉本英彦・名取宏美 (2001). Child Behavior Checklist/4-18 日本語版の開発 小児の精神と神経, 41, 243-252.
- 岩坂英巳 (編) (2012). 困っている子をはめて育てるペアレント・トレーニングガイドブック—活用のポイントと実践例—— じほう
- 金 喬・米山直樹 (2017). ペアレント・トレーニングの効果測定を目的とする KBPA 追加項目作成の試み 日本行動分析学会第35回年次大会発表論文集, 69.
- 小嶋雅代・古川壽亮 (2003). BDI-II ベック抑うつ質問票 (日本版) 日本文化科学社
- Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M. A., Polatajko, H., & Pollock, N. (1998). *Canadian Occupational Performance Measure* (3rd ed.). Ottawa, ON: CAOT ACE. (吉川ひろみ・上村智子 (監訳) (2001). COPM——カナダ作業遂行測定——第2版 大学教育出版)
- Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). *Manual for Depression Anxiety Stress Scales* (2nd ed.). Sydney, Australia: The Psychology Foundation of Australia.
- 松岡弥玲・岡田 涼・谷 伊織・大西将史・中島俊思・辻井正次 (2011). 養育スタイル尺度の作成: 発達的变化と ADHD 傾向との関連から 発達心理学研究, 22, 179-188.
- 中川泰彬・大坊郁夫 (1996). 日本版 GHQ 精神的健康調査票手引き 日本文化科学社
- 中嶋和夫・齋藤友介・岡田節子 (1999). 母親の育児負担感に関する尺度化 厚生指針, 46, 11-18.
- 奈良間美保・兼松百合子・荒木暁子・丸 光恵・中村伸枝・武田淳子・工藤美子 (1999). 日本版 Parenting Stress Index (PSI) の信頼性・妥当性の検討 小児保健研究, 58, 610-616.
- O'Dell, S., Tarler-Benlolo, L., & Flynn, J. M. (1979). An instrument to measure knowledge of behavioral principles as applied to children. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 10, 29-34.
- 岡田節子・種子田 綾・新田 収・中嶋和夫 (2004). 障害児育児ストレス認知尺度の因子不変性 静岡県立大学短

- 期大学部研究紀要, 18, 183-190.
- 大野裕史・諸岡輝子・永尾貴子・見城圭美・免田 賢・日上耕司・津川秀夫 (2005). 発達障害児を持つ親に対する支援プログラムの効果 (1) 吉備国際大学臨床心理相談研究所紀要, 2, 17-31.
- 大野 裕・吉村公雄 (2001). WHO SUBI 手引き 金子書房
- Prizant, B. M., Wetherby, A. M., Rubin, E., Laurent, A. C., & Rydell, P. J. (2006). *The SCERTS Model: A comprehensive educational approach for children with autism spectrum disorders*. Vol. 1. *Assessment*. Baltimore, MD: Paul H. Brookes. (プリザント, B. M., ウェザビー, E. M., ルービン, E., ローレント, E. C., ライデル, P. J. 長崎勤・吉田仰希・仲野真史 (監訳) (2010). SCERTS モデル—自閉症スペクトラム障害の子どもたちのための包括的教育アプローチ 1 巻アセスメント 日本文化科学社)
- Robin, A. L. (1981). A controlled evaluation of problem-solving communication training with parent-adolescent conflict. *Behavior Therapy*, 12, 593-609.
- Sanders, M. R., Markie-Dadds, C., Rinaldis, M., Firman, D., & Baig, N. (2007). Using household survey data to inform policy decisions regarding the delivery of evidence-based parenting interventions. *Child: Care, Health and Development*, 33, 768-783.
- 志賀利一 (1983). 行動変容法と親トレーニング (その知識の獲得と測定) 自閉症児教育研究, 6, 31-45.
- 品川不二郎・品川孝子・森上史朗・河井芳文 (1972). TK 式診断的新親子関係検査手引き 田研出版
- 鈴木伸一・嶋田洋徳・三浦正江・片柳弘司・右馬埜力也, 坂野雄二 (1997). 新しい心理的ストレス反応尺度 (SRS-18) の開発と信頼性・妥当性の検討 行動医学研究, 4, 22-29.
- 田坂一子 (2003). 育児自己効力感 (parental self-efficacy) 尺度の作成 甲南女子大学大学院論集, 1, 1-10.
- 手島聖子・原口雅浩 (2014). 育児不安の構造 久留米大学心理学研究, 3, 83-88.
- 戸ヶ崎泰子・坂野雄二 (1997). 母親の養育態度が小学生の社会的スキルと学校適応におよぼす影響—積極的拒否型の養育態度の観点から— 教育心理学研究, 45, 173-182.
- 上野一彦・岡田 智 (2006). 特別支援教育 実践 ソーシャルスキルマニュアル (pp. 140-143) 明治図書出版
- 梅津耕作 (1982). KBPAC (Knowledge of Behavioral Principles as Applied to Children) 日本語版 行動療法研究会
- 涌水理恵・藤岡 寛・古谷佳由理・宮本信也・家島 厚・米山 明 (2010). 障害児を養育する家族のエンパワメント測定尺度 Family Empowerment Scale (FES) 日本語版の開発 厚生指針, 57, 33-41.
- 山上敏子 (監修) (1998). 発達障害児を育てる人のための親訓練プログラムお母さんの学習室 二瓶社
- 山川玲子・柏木恵子 (2004). 母親の子ども・育児感情—虐待の温床としての育児不安の要因— 文京学院大学研究紀要, 6, 185-200.
- 山崎晃資・小石誠二・朝倉 新 (2000). AD/HD-Rating Scale-IV の日本語版の作成 日本児童青年精神医学総会抄録集, 41, 159.

REVIEW

Training for Parents of Children With Developmental Disabilities in Japan: An Updated Systematic Review

HONAMI YAMAGUCHI

Tokorozawa City Child Support Center¹⁾

AKANE YOSHIMOTO

Toride City Offices

HIDEYUKI HARAGUCHI

National Institute of Mental Health, National Center of Neurology and Psychiatry

Abstract

The present report, which systematically reviews the literature on parent training (PT) for parents of children with developmental disabilities in Japan, aims to provide an update on recently published evidence. In total, 51 studies published between 2012 and 2018 were analyzed for sample size, child characteristics, parent training programs, and effectiveness. The average sample size was 11 parents and 10 children. School-age children were included in 69% of the studies, preschool children in 59%, and children with developmental disabilities in 80%. Of the studies included in the review, 35% examined the effectiveness of standard parent training programs used in Japanese community settings. To evaluate effectiveness for parents, 77% used psychological tests, 18% used observational data, 80% used a pretest-posttest design, and 16% used a single-case experimental design. To evaluate effectiveness for children, 55% used psychological tests, 29% used observational data, 57% used a pretest-posttest design, and 28% used a single-case experimental design. Of the studies reviewed, 6 examined effectiveness of a parent training group and a comparison group. The present review revealed evidence for the effectiveness of parent training; specifically, most of the published studies that were reviewed reported positive changes in various parent and child outcomes. Limitations in the studies include small sample size, few comparative studies, lack of detailed information on the participants and programs, and insufficient reporting regarding fidelity of implementation parent training, participation rates, and program evaluation. Future studies of the effectiveness of parent training should utilize more rigorous designs with a larger number of participants, and should report detailed information on the participants, programs, and evaluation methods and results.

Key Words parent training (PT), developmental disabilities, effectiveness, evidence, systematic review